



Helse- og omsorgsdepartementet

Vår referanse
24/00934-2

Dato
14. mars 2025

Den norske tannlegeforenings høringssvar til NOU 2024:18 En universell tannhelsetjeneste

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 2. oktober 2024 hvor departementet ber om høringsinstansenes syn på Tannhelseutvalgets vurderinger og forslag i *NOU 2024:18 En universell tannhelsetjeneste* (utredning).

Den norske tannlegeforening (NTF) oversender med dette vårt høringssvar.

NTF er profesjonsorganisasjonen for alle landets tannleger, inkludert tannlegespesialister, og har en medlemsoppslutning på ca. 95 %. Foreningen har rundt 6 700 medlemmer, derav ca. 10 % spesialister. Av foreningens yrkesaktive medlemmer arbeider ca. 70 % i den private tannhelsetjenesten og ca. 30 % i den offentlige tannhelsetjenesten, hovedsakelig i fylkeskommunen. Blant de ansatte i offentlig sektor har vi også medlemmer som jobber i offentlig forvaltning, tjenestegjør i forsvaret, er vitenskapelig ansatte, er under spesialistutdanning eller er stipendiater.

Høringsuttalelsen har vært behandlet i alle organisasjonsledd i foreningen.

NTF vil innledningsvis bemerke at det er en omfattende utredning. NTF kan ikke tas til inntekt for å støtte utvalgets syn der beskrivelser eller problemstillinger ikke er kommentert.

Videre vil vi understreke at når det i høringsuttalelsen henvises til tannhelsetjenesten så viser det til både den offentlige og den private delen av tannhelsetjenesten. Benevnelsen DOT viser til dagens offentlige tannhelsetjeneste i fylkeskommunen.

Tannhelseutvalget kommer med 40 forslag. Hovedforslaget er at alle skal ha rett til nødvendige tannhelsetjenester. Utvalget har gitt sin tilslutning til 34 forslag, mens det er uenighet om de resterende forslagene.

Den norske tannlegeforenings høringssvar til NOU 2024:18 En universell tannhelsetjeneste	1
DEL I – OPPSUMMERING AV HOVEDPUNKTER	4
DEL II – GENERELLE INNSPILL	6
1 Om tannhelsetjenesten – generelt.....	6
2 Om datainnsamling – generelt.....	7
DEL III – NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR NTFs HOVEDSYNSPUNKTER	8
1 Målet er en universell tannhelsetjeneste.....	8
2 Den offentlige tannhelsetjenesten må forankres på regionalt nivå	10
2.1 Harmonisert modell (syv utvalgsmedlemmer)	11
2.2 Regionale tannhelseforetak (fire utvalgsmedlemmer inkl. NTFs president)	13
2.3 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (to utvalgsmedlemmer)	16
3 Rammer og reguleringer for privat sektor	17
3.1 Om prisregulering	19
3.2 Om prisportal	20
3.3 Om plikt til å informere om klagemuligheter	20
3.4 Om styrking av dagens tilsynsordninger	21
3.5 Om konsesjonsordninger	21
4 En universell tannhelsetjeneste - trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret	23
DEL IV - NTFs INNSPILL TIL KAPITTEL 12 UTVALGETS VURDERINGER AV DAGENS TANNHELSETJENESTE	24
12.1 Behov for en universell tannhelsetjeneste	24
12.2 Tannhelsen i befolkningen blir stadig bedre	24
12.3 Geografisk tilgjengelighet	25
12.4 Behov for likeverdig tilgang til tannhelsetjenester for alle	26
12.4.1 Behov for kontinuerlig arbeid med forebygging	26
12.4.2 Behov for et helhetlig ansvar for barn og unge	27
12.4.3 Behov for å ivareta utsatte og sårbare grupper	27
12.4.4 Behov for å ivareta eldre med kognitiv svikt og skrøpelighet.....	28
12.4.5 Behov for å se sammenhengen mellom oral sykdom/skade og øvrig helse	29
12.4.6 Behov for å redusere risiko for store utgifter.....	29
12.4.7 Behov for å styrke pasientenes kunnskap om prisnivået.....	30
12.5 Behov for å sikre tannhelsetjenester av god kvalitet.....	31
12.5.1 Behov for å styrke kvaliteten på tjenestene	31

12.5.2 Behov for å styrke tannhelsetjenestens ansvar for forskning og praksis i utdanningene	32
12.5.3 Behov for å vurdere videre innretningen av tjenesteinnovasjon	32
12.5.4 Behov for økt digitalisering.....	33
12.6 Behov for å vurdere klageordninger og økt tilsyn	33
12.7 Behov for samhandling og samordning med helse-, omsorgs- og sosialtjenester	33
12.7.1 Behov for bedre samhandling med helse-, omsorgs- og sosialtjenester	33
12.7.2 Behov for å integrere tannhelsetjenester i øvrig helse- og omsorgstjeneste i større grad	34
12.7.3 Behov for å samordne helseberedskapen.....	34
12.7.4 Behov for å sikre rett dimensjonering og effektiv bruk av personell	34
12.8 Behov for å tydeliggjøre rammene for den private tannhelsetjenesten	35
12.9 Behov for å vurdere forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten	36
12.10 Behov for bedre kunnskapsgrunnlag	38
DEL V – NTFs INNSPILL TIL KAPITTEL 13 EN UNIVERSELL TANNHELSETJENESTE – UTVALGETS FORSLAG.....	38
1 Målet er en universell tannhelsetjeneste.....	38
2 Likeverdig tilgang til tannhelsetjenester for alle	39
3 Tannhelsetjenester av god kvalitet.....	44
4 Klageadgang, tilsyn og pasientsikkerhet	48
5 Samhandling, styring og ansvar for tannhelsetjenesten	48
6 Tydeliggjøre rammene for utøvelse av privat virksomhet	50
7 Tannhelsesdata som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av tannhelsetjenesten	51

DEL I – OPPSUMMERING AV HOVEDPUNKTER

- 1) **Universell tannhelsetjeneste.** NTF støtter innføring av en universell tannhelsetjeneste som i fremtiden vil gi befolkningen rett og tilgang til **nødvendige** tannhelsetjenester, slik de har rett og tilgang til nødvendige helse – og omsorgstjenester.
- 2) **Økt offentlig finansiering** er avgjørende for å sikre hele befolkningen tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.
- 3) **Både offentlig og privat tannhelsetjeneste må levere tjenester til befolkningen.** Ressursene og kompetansen i hele tannhelsetjenesten, både den offentlige og private, må utnyttes i fremtidens tannhelsetjeneste for å sikre befolkningen rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester av høy kvalitet. Det må utredes nærmere hvordan dette kan gjøres.
- 4) **Gode og forutsigbare rammebetingelser for tjenesten.** Det må sikres gode og forutsigbare rammebetingelser for både den offentlige og private delen av tannhelsetjenesten for å kunne løse oppgavene i en universell tannhelsetjeneste.
- 5) **Nødvendige tannhelsetjenester.** Det må utredes nærmere, i samarbeid med fagmiljøene i hele tannhelsetjenesten, hva som er nødvendig tannhelsetjenester.
- 6) **Tannregulering for barn og unge.** Det må utredes nærmere hva som skal anses som nødvendig tannregulering for barn og unge og innføre kostnadsfri nødvendig behandling.
- 7) **Frikort.** Dagens frikort for helsetjenester må utvides til å inkludere nødvendige tannhelsetjenester. NTF er skeptiske til et eget frikort for tannhelsetjenester.
- 8) **Trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret.** NTF støtter en prinsipiell tilnærming i en trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester.
- 9) **Regionale tannhelseforetak.** Tannhelsetjenester er spesialiserte tannhelsetjenester og tannhelsetjenestene bør derfor organiseres som egne regionale tannhelseforetak, på linje med helseforetakene i dagens spesialisttannhelsetjeneste. Dette vil sikre bedre nasjonal styring og nødvendige tannhelsetjenester til hele befolkningen.
- 10) **Integrasjon med resten av helsetjenesten og inkludering i e-helse – og beredskapsarbeidet.** NTF mener at tannhelsetjenesten må integreres bedre med resten av helsetjenesten, og at tannhelsetjenesten må inkluderes i e-helsearbeidet og sikres tilgang til digitale løsninger på lik linje med resten av helsetjenesten. NTF støtter også at tannhelsetjenesten må inkluderes i beredskapsplaner på alle nivåer.
- 11) **Konsolidering og økt kommersielt eierskap.** NTF er bekymret for konsekvensene av konsolidering og økende eierskap av investor-eide kjeder i den private tannhelsetjenesten, og påpeker at dette kan sette den faglig autonomi under press. Det må legges til rette for at tannleger fortsatt skal kunne eie og drive små og mellomstore virksomheter.
- 12) **Ingen prisregulering uten utredning.** NTF støtter ikke forslag om prisregulering uten en grundig utredning av innretning og konsekvenser.

- 13) **Konsesjonsordninger.** NTF støtter ikke forslagene om særegne konsesjonsordninger for tannhelsetjenesten. De foreslåtte konsesjonene vil fremme utviklingen med kjededannelse på bekostning av mindre tannlegeeide virksomheter.
- 14) **Økonomiske og administrative konsekvenser er lite utredet.** Gjennomgående vil Tannhelseutvalgets forslag kreve nærmere utredning og økt offentlig finansiering før de vil kunne iverksettes. Det må sikres at offentlige myndigheter tar ansvar for at befolkningen får rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Det er også et offentlig ansvar å finansiere ulike tiltak for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet, innovasjon og digitalisering i tannhelsetjenesten, som i resten av helsetjenestene.
- 15) **EØS-rettslig konsekvensvurdering mangler.** NTF viser til at ingen av utvalgets forslag er utredet opp mot EØS-retten og støtter utvalget på at slike utredninger må gjennomføres før man kan gå videre med flere av forslagene i NOUen. Eksempelvis nevnes forslag til utvidet frikortordning, størrelsen på pasientenes egenbetaling, utvidelse av offentlig tannhelsetjenestes oppgaver, inngåelse av ulike avtaler med privat tannhelsetjeneste og bruk av anbudskonkurranser. Listen er ikke uttømmende.

DEL II – GENERELLE INNSPILL

1 Om tannhelsetjenesten – generelt

NTF støtter Tannhelseutvalget i at det er nødvendig å utvikle en bærekraftig tannhelsetjeneste basert på samfunnets behov. Utredningen fastslår at det er behov for en universell tannhelsetjeneste og at det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester bør utvides. Tannhelsetjenesten bør styrkes og integreres med øvrige helse- og omsorgstjenester. Offentlig og privat tannhelsetjeneste bør samhandle for å sikre bruk av all tilgjengelig kompetanse. NTF stiller seg bak dette, og støtter de mål og verdier utvalget skisserer i kapittel 11 *Overordnede verdier og mål*. Målet for fremtidens tannhelsetjeneste må være en sosial utjevning av ulikhet i tann- og munnhelse og en god tann- og munnhelse i hele befolkningen.

NTF vil likevel understreke at en endring av tannhelsetjenesten må være kunnskapsbasert. Det mangler fortsatt kunnskap om både helheten av, og deler av tannhelsetjenesten, og svært mange av utvalgets forslag må utredes videre før man kan gjennomføre endringer. Tannhelsetjenestens særpreg og ordninger som fungerer i dag bør ivaretas og videreutvikles i fremtidens tannhelsetjeneste, samtidig som tannhelsetjenesten bør integreres med resten av helsetjenesten. Slik kan hele befolkningen sikres tilgang til nødvendige offentlige finansierte tannhelsetjenester på en bedre måte.

Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig og en privat del, hvor den private delen utgjør ca. 70 % av den samlede tjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) som er organisert i fylkeskommunen ivaretar barn og unge og andre prioriterte grupper etter tannhelsetjenesteloven. DOT kan også tilby behandling til den delen av den voksne befolkningen som ikke har krav på behandling etter tannhelsetjenesteloven, i områder hvor det ikke er tilstrekkelig dekning av private tannhelsetilbydere eller dersom de har ledig kapasitet. Den private tannhelsetjenesten gir et tilbud til resten av befolkningen, og utgjør derfor en meget viktig del av befolkningens tannhelsetilbud. NTF er av den oppfatning at den eneste muligheten for å sikre befolkningen et nødvendig og tilstrekkelig tannhelsetilbud i fremtiden vil være å legge til rette for et godt samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste, slik at ressursene og kompetansen i den private tannhelsetjenesten kan utnyttes på best mulig måte.

Tannhelsetjenesten er i dag organisert og finansiert på en helt annen måte enn resten av helsetjenesten. Det gjør det krevende å få til god samhandling med andre helsetjenester, og det svekker pasientsikkerheten. Det er viktig å sikre en harmonisering med resten av helsetjenestene som legger til rette for samarbeid og samhandling. Tannhelsetjenesten må inkluderes på en bedre måte i det videre arbeidet med e-helse, og det må sikres at tannhelsetjenesten får tilgang til digitale løsninger som utvikles.

Manglende finansiering av nødvendige tannhelsetjenester gjør at det er sosial ulikhet i tann- og munnhelse i dag og at mange ikke har råd til å få utført nødvendig tannbehandling. Tann- og munnhelse må ses i sammenheng med somatisk og psykisk helse. I fremtiden må befolkningen ha rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, slik de har rett og tilgang til nødvendige helse – og omsorgstjenester. Det må være behovet for tannhelsehjelp som legger grunnlaget for den tannhelsehjelpen som gis. Prioriteringskriteriene som benyttes i resten av helsetjenesten må implementeres i tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenesten er en kostnadsintensiv tjeneste som i all hovedsak tilbyr avansert klinisk behandling. Tannbehandling krever klinikker med høyteknologisk kostbart og avansert utstyr (unit/tannlegestol, kompressor, røntgenutstyr, mulighet for sterilisering av utstyr mm.) og personell med høy kompetanse. Tannhelsetjenesten sammenliknes best med spesialisthelsetjenesten og den spesialiserte behandlingen som utføres i sykehus, i

poliklinikker og hos andre private legespesialister. Selv om formålet med behandlingen blant annet er å forebygge infeksjon og videre utvikling av sykdom, er selve behandlingen mer komplisert. En tannhelsetjeneste som sikrer befolkningen tilgang til nødvendig tannbehandling vil avlaste resten av helsetjenesten og bidra til at ressursene i helsetjenesten brukes riktig.

Tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere er alle viktige yrkesgrupper i tannhelseteamet. Alle har sine egne kompetanseområder og arbeidsoppgaver på bakgrunn av sin utdanning. For at tannhelsetjenesten skal fungere må Norge ha tilstrekkelig antall tannhelsepersonell. Det er avgjørende for en harmonisering av tannhelsetjenesten med resten av helsetjenesten og for innføringen av en universell tannhelsetjeneste hvor hele befolkningen har rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

Tannhelsetjenesten er en viktig helsetjeneste også i beredskapssammenheng. Tjenesten tilbyr nødvendig behandling av traumer, smerter, skader og infeksjoner og avlaster på den måten resten av helsetjenesten. Tannhelsepersonell har dessuten god kompetanse på smittevern og annen medisinsk kompetanse. Det må sikres at hele tannhelsetjenesten er involvert i beredskapsplaner slik at kompetansen og ressursene utnyttes på best mulig måte.

2 Om datainnsamling – generelt

Utvalget kommenterer i *Kapittel 1 Innledning* at det har vært krevende å få tilgang til data, spesielt fra privat tannhelsetjeneste. Utvalget sendte 21. mars 2024 et brev til departementet. NTF kommenterer dette i vårt svar til departementet 28. mai 2024 (utredningens vedlegg 5).

NTF vil understreke at vi hele tiden har vært, og fortsatt er, positive til innsamling av data fra privat tannhelsetjeneste. Vi har på ingen måte forsøkt å hindre datainnsamling fra tjenesten, noe som illustreres ved at vi har oppfordret medlemmene til å svare på alle spørreundersøkelser som er sendt ut, og at NTF har bidratt i både utarbeidelsen og tolkningen av Vistas undersøkelse som ble bestilt av utvalget.

NTF har vært positive til innhenting av data til KPR, innenfor rammene av formålet til KPR. Vi har også vært tydelige på at lovverket må følges i disse prosessene, noe vi legger til grunn at departementet er enig i.

Det må være myndighetenes ansvar å ha kunnskap og oversikt over tannhelsetjenesten i Norge. NTF er en medlemsorganisasjon. Vi bidrar i alle prosesser som er i gang for å kunne hente ut data fra tannhelsetjenesten, men NTF kan ikke lastes for at det så langt ikke er lagt til rette for nødvendig datainnhenting fra tjenesten.

DEL III – NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR NTFs HOVEDSYNSPUNKTER

Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten. Utvalgets hovedanbefaling er en universell tannhelsetjeneste og en harmonisering med resten av helsetjenesten. Med et slikt premiss er det noen av anbefalingene fra utvalget som ikke vil være nødvendige. NTF vil komme tilbake til dette under de konkrete anbefalingene.

Vi vil videre komme med NTFs hovedkonklusjoner og hvilke premisser vi legger til grunn for disse.

1 Målet er en universell tannhelsetjeneste

Utvalgets hovedkonklusjon er:

Målet er en universell tannhelsetjeneste

Forslag 1. Alle skal ha rett til nødvendige tannhelsetjenester

NTF støtter at det innføres en universell tannhelseordning hvor befolkningen har rett til nødvendig tannhelsehjelp, ved sykdom og skade i munn og munnhule, slik pasientene har ved somatisk og psykisk sykdom og skade. Forslaget innebærer videre at det skal være et offentlig ansvar å gi nødvendig tannhelsehjelp, men det betyr ikke at tjenestene må leveres av det offentlige. Tjenestene kan og må, etter NTFs mening, leveres gjennom et samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste.

Munnhelse er helse og tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten. Hele befolkningen skal ha tilgang til offentlig finansierte nødvendige tannhelsetjenester når de har behov for det, på lik linje med andre helsetjenester. NTF vil understreke at det har vist seg at målrettede ordninger, slik vi har i dag, ikke treffer de som har størst behov. Det er fortsatt store sosiale ulikheter i befolkningens munnhelse og det er store grupper som faller utenfor i dagens system. NTF mener derfor at en universell tannhelseordning må innføres slik at vi sikrer at alle får tilgang til nødvendig tannhelsehjelp.

Det overordnede målet for den norske universelle og skattefinansierte helsetjenesten er å bidra til å sikre hele befolkningen lik tilgang til tjenester av god kvalitet (pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1). Den enkelte borger har rett til nødvendig helsehjelp, gitt medisinsk behov. På samme måte må den enkelte borger ha rett til nødvendig tannhelsehjelp ved odontologisk behov. Tjenestetilbudet skal prioriteres etter definerte kriterier som i resten av helsetjenesten: nytte, ressurs og alvorlighet, inkludert mestringsbegrepet. Det må utarbeides nasjonale faglige retningslinjer og prioriteringsveiledere, for å kunne vurdere omfanget og kvaliteten av behandlingstilbudet på tannhelsefeltet.

Det må utredes hva som skal defineres som nødvendige tannhelsetjenester og hvilke tjenester det offentlige skal finansiere. NTF mener at prioriteringskriteriene som brukes i primær- og spesialisthelsetjenestene også må legges til grunn når man skal utrede hva som er nødvendig tannbehandling. En slik utredning bør ledes av et bredt utvalg sammensatt av representanter fra de odontologiske fagmiljøene, klinisk erfarne tannleger i begge sektorer, og dessuten representanter fra profesjonsforeningene i tannhelsetjenesten. NTF vil understreke at et

nødvendig nivå av forebyggende behandling og regelmessig oppfølging av pasienter i forebyggende øyemed må inkluderes i nødvendige tannhelsetjenester.

WHO definerer nødvendige tannhelsetjenester som de tjenestene som er essensielle for å opprettholde god oral helse og forebygge sykdommer, understreker at alle bør ha tilgang til slike tjenester.¹

Nødvendige tannhelsetjenester inkluderer:

- Akutt tannbehandling
- Undersøkelse samt helsefremmende og forebyggende tjenester inkl. opplæring i egenomsorg
- Behandling av sykdom og patologiske tilstander
- Restorative tjenester og erstatning av tapte tenner for å gjenopprette funksjon og estetikk

I den norske tannhelsetjenesten foreligger en veileder fra Helsedirektoratet om *God klinisk praksis* fra 2011.² Dette innebærer å tilby behandling basert på beste tilgjengelige kunnskap og faglig skjønn. Veilederen fra Helsedirektoratet gir detaljerte retningslinjer for hvordan tannhelsepersonell skal utføre sitt arbeid for å sikre høy kvalitet og pasientsikkerhet. Veilederen begynner å bli gammel, men den kan likevel være et utgangspunkt for det videre utredningsarbeidet.

Tannhelsetjenesten må, som en del av helsetjenesten, ha ansvar for å levere tannhelsetjenester til hele befolkningen, inkludert helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er odontologiske behov som må være avgjørende for prioritering av nødvendig og forsvarlig tannbehandling på individnivå.

Myndighetene må sørge for tilstrekkelig finansiering av tannhelsetjenester for å innfri en universell rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Som resultat av Tannhelseutvalgets arbeid forventer NTF at myndighetene legger en helhetlig strategi med mål om økt finansiering av tannhelsetjenester. Dette skal sikre hele befolkningen et likeverdig tannhelsetilbud av høy kvalitet og bidra til å utjevne de sosiale ulikhetene i munnhelse.

Orale sykdommer har samme risikofaktorer som andre ikke-smittsomme sykdommer. De store sykdomsgruppene som i dag ligger innenfor Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon av ikke-smittsomme sykdommer, står for en stor andel av sykdomsbyrden både i verden og i Norge. Det er fastslått sammenheng mellom orale sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer. Alle disse sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom tiltak rettet mot felles underliggende risikofaktorer. Grunnlaget for god folkehelse legges ikke i helsetjenesten. Ikke-smittsomme sykdommer må forebygges ved redusert bruk av alkohol og tobakk, gode kostvaner og økt fysisk aktivitet. Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene kan utviklingen og forløpet av flere sykdommer påvirkes samtidig. Gjennom folkehelsearbeidet må samfunnet påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse, og på den måten legge til rette for at befolkningen skal kunne ta kloke og sunne valg. Dette er et myndighetsansvar.

WHO har vedtatt en historisk resolusjon om tannhelse og dessuten en Global Oral Health Action Plan (2023-2030). Norge har sluttet seg til dette arbeidet. WHO slår fast at det er sosial ulikhet og en sosial gradient i helse, og at dette kan motvirkes. Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer på nasjonalt nivå. Tannhelsetjenesten må ta, og ha, en sentral plass i

¹ <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376623/9789240090538-eng.pdf?sequence=1>

² [www.helsedirektoratet.no/veiledere/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten/God%20klinisk%20praksis%20i%20tannhelsetjenesten%20-%20Veileder%20\(fullversjon\).pdf](http://www.helsedirektoratet.no/veiledere/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten/God%20klinisk%20praksis%20i%20tannhelsetjenesten%20-%20Veileder%20(fullversjon).pdf)

folkehelsearbeidet gjennom økt samhandling med den øvrige helsetjenesten. Tannhelsetjenesten må bidra i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og dette må være en viktig del av tannhelsetilbudet til befolkningen. Måltrettet helsefremmende og forebyggende arbeid bidrar til god munnhelse.

Munnhelse er like viktig i et livsløpsperspektiv som øvrig helse. God munnhelse innebærer at man ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser og sykdom i munnhulen, at man har tilfredsstillende tyggefunksjon og at man kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene og munnen. En frisk munn er viktig for god helhetlig helse (fysisk, psykisk og sosial), for god motstandskraft mot sykdom, for god ernæring og for god samhandling med andre mennesker. Tilgang til nødvendig tannbehandling vil dessuten hindre infeksjon og dermed minske behovet for behandling i resten av helsevesenet.

Økt offentlig finansiering er avgjørende for at hele befolkningen skal få rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, på lik linje med andre helsetjenester. I fremtidens tannhelsetjeneste må målet være å sikre at økonomi ikke utgjør en barriere for å motta tannhelsehjelp. NTF vil understreke at den offentlige finansieringen må være tilstrekkelig for å opprettholde gode rammevilkår for hele tannhelsetjenesten, både offentlig og privat, slik at tjenesten kan levere nødvendig tannbehandling av høy kvalitet. Det er viktig at finansieringen følger kostnadsveksten i samfunnet og også sikrer innovasjon og utvikling i tjenesten, slik at nye behandlingsmetoder og utstyr kan tas i bruk og tilgjengeliggjøres når det er hensiktsmessig.

Ca. 70 % av NTFs medlemmer er tilknyttet den helprivate delen av tannhelsetjenesten, som ikke mottar noen form for offentlig finansiering, hverken til etablering eller drift. NTF er av den klare oppfatning av at det eneste realistiske alternativet for å få etablert en universell tannhelsetjeneste er å tilrettelegge for et godt samarbeid og en god arbeidsfordeling mellom den offentlige og den private delen av tannhelsetjenesten.

Økt offentlig finansiering av tannhelsetjenester kan ikke bety at all tannbehandling skal utføres av den offentlige delen av tannhelsetjenesten. Tvert imot blir det viktig i fremtidens tannhelsetjeneste å utnytte kompetansen i hele tannhelsetjenesten for å sikre hele befolkningen tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Det må legges til rette for en modell der privat tannhelsetjeneste kan utføre nødvendig offentlig finansiert tannbehandling etter avtale med myndighetene. Hvordan et slikt system best bør innrettes og hvilke avtaler som må inngås, må utredes nærmere. Rammebetingelsene for tannhelsetjenesten må være forutsigbare og stabile. Avtaler bør inngås mellom det enkelte helsepersonell og myndighetene, slik det er i resten av helsetjenesten (avtaler som regulerer pris, kvalitet, plikter og rettigheter).

2 Den offentlige tannhelsetjenesten må forankres på regionalt nivå

Utvalget er tredelt i spørsmålet om forvaltningsnivå som skal ha ansvaret for organisering av den offentlig finansierte tannhelsetjenesten. Et flertall i utvalget mener at ansvaret for den offentlig finansierte tannhelsetjenesten uansett må flyttes ut av fylkeskommunen.

De tre ulike forslagene for hvilket forvaltningsnivå offentlig finansierte tannhelsetjenester bør organiseres på er som følger:

1. Harmonisert modell (syv utvalgsmedlemmer)

2. Regionale tannhelseforetak (fire utvalgsmedlemmer inkl. NTFs president)

3. Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (to utvalgsmedlemmer)

NTF støtter mindretallet i utvalget som foreslår regionale tannhelseforetak, og vi vil i det følgende begrunne vår konklusjon.

2.1 Harmonisert modell (syv utvalgsmedlemmer)

NTF er svært kritisk til den harmoniserte modellen.

Utvalgets flertall tilrår i kapittel 15 *Organisering av den offentlige tannhelsetjenesten*, at ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommunalt til kommunalt nivå, med unntak av spesialisttannhelsetjenester som foreslås organisert i de regionale helseforetakene. Dette kalles den *harmoniserte modellen*. I denne modellen vil tannhelsetjenesten følge organiseringen, reguleringen og finansieringen av den øvrige helsetjenesten. Kommunene vil få ansvar for å yte nødvendige forebyggende og oppsøkende tjenester og andre allmenntannhelsetjenester til alle innbyggere, gitt utvalgets forslag om en universell rett til nødvendig tannhelsehjelp.

I denne modellen vil tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre overføres til de regionale helseforetakene.

Det vises til Prop. 71L (2016-2017)³ og uttales at: *Videre utredning av den harmoniserte modellen anbefales å bruke dette underlaget med hensyn til ansvarsoverføring av allmenntannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene* (15.3.4, side 235).

Forslagene i Prop. 71L (2016-2017), ble nedstemt av Stortinget i 2017. Det ble samtidig vedtatt en forsøksordning, slik at kommuner som ønsket det kunne søke om å få overta ansvaret fra 2020. Dette ble heller aldri satt ut i livet. Forslaget om *harmonisert modell* fremstår følgelig som en omkamp, til tross for at premissene for forslaget i 2017 ikke er oppfylt.

NTF var sterkt kritisk til forslaget om å overføre DOT fra fylkeskommune til kommune, i sin høringsuttalelse av 30. september 2016⁴. NTFs standpunkt forblir uendret. NTF mener det er uforsvarlig å vedta at kommunene skal ha ansvar for en spesialisert tjeneste som tannhelsetjenesten er. Det vil være svært krevende for kommunene å ha ansvar for tannbehandling til hele befolkningen.

NTF mener at flertallets forslag vil kunne få svært uheldige konsekvenser for hele tannhelsetjenesten, både den offentlige og den private, og ikke minst for pasientene. NTF mener at forslaget vil svekke pasientsikkerheten fordi det medfører betydelig usikkerhet når det gjelder muligheten for å opprettholde et forsvarlig, velfungerende og helhetlig tannhelsetilbud til befolkningen.

En forutsetning for å flytte tannhelsetjenesteansvaret forrige gang var store og robuste kommuner som var i stand til å utføre oppgaven. Denne forutsetningen er ikke oppfylt, selv om antall kommuner ble redusert i 2017. Det er 357 kommuner i Norge, hvorav svært mange har et lavt innbyggertall. Minst 50 kommuner har ikke tannklinikk (side 235, jf. kapittel 3). Fylkeskommunene har i betydelig grad lagt ned og sentralisert offentlige tannklinikker.

³ Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-71-l-20162017/id2546178/>

⁴ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nye-oppgaver-til-storre-kommuner/id2500822/?uid=6b536688-db9e-4ae4-b4e2-409039d8a626>

Forslaget forutsetter dermed omfattende interkommunalt samarbeid, som hverken er politisk eller faglig ønskelig.

Samfunnsutviklingen de senere årene har ytterligere svekket kommunenes forutsetning for å overta ansvaret for tannhelsetjenesten. Det vil nå være enda mer krevende å overføre ansvaret for tannhelsetjenester til hele befolkningen til kommunene enn å overføre ansvaret for DOT slik det ble foreslått den gang. Den alvorlige krisen i kommuneøkonomien gjør at mange kommuner sliter med å utføre allerede lovpålagte og krevende samfunnsoppgaver. Forslaget vil dessuten føre til at den offentlige tannhelsetjenesten mister stordriftsfordelene ved at tjenesten er organisert på regionalt nivå. Det bemerkes at DOT i dag allerede er underfinansiert på fylkeskommunalt nivå. En overføring til kommunene vil nødvendigvis føre til en betydelig økning i investeringskostnader, administrasjon- og driftskostnader, sammenliknet med dagens organisering.

KS påpeker i sin høringsuttalelse til NOU 2024:18 at *Endringer i dagens forvaltningsnivå [til kommunene] gir økt risiko for å pulverisere ansvaret i tannhelsetjenesten, som er en allerede liten og spesialisert tjeneste*. NTF deler dette synspunktet.

Å rekruttere og beholde høyt utdannede, herunder tannleger, er en generell utfordring i mange distriktskommuner. Forslaget vil føre til en oppsplitting og fragmentering av sterke fagmiljøer i fylkeskommunene. Mindre klinikker vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere og beholde tannleger. Forholdet til offentlig ansatte tannleger er særdeles overfladisk behandlet. En virksomhetsoverdragelse fra fylkeskommune til kommune vil være svært krevende å gjennomføre administrativt, økonomisk og juridisk.

I den harmoniserte modellen vil kommunene gis ansvar for helsefremmende, forebyggende og primære tannhelsetjenester. Staten ved de regionale helseforetakene gis ansvaret for spesialisttannhelsetjenesten og de regionale kompetansesentrene. NTF er svært kritisk til dette. Tannhelsetjenesten er en spesialisert tjeneste som er avhengig av spesialisert fagkompetanse. Størrelsen på fagmiljøene er av avgjørende betydning, og det er svært uheldig å splitte en relativt liten tjeneste, som tannhelsetjenesten, på flere nivåer. Hverken helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten besitter kompetanse til å kunne overta tannhelsetjenesten i dag, så dette vil kreve store endringer og tilpasninger i tjenestene. Dette er en av grunnen til at NTF mener at det beste alternativet for en fremtidig modell er regionale tannhelseforetak.

Det er også uklart hvilke konkrete oppgaver flertallet mener at kommunene skal ha ansvaret for i den harmoniserte modellen, og hvilke oppgaver som skal utføres i spesialisthelsetjenesten. Mange spesialiserte oppgaver utføres i dag i tannhelsetjenesten av allmenntannleger, og svært få behandlinger er forbeholdt spesialister i dagens tannhelsetjeneste. Det er kompetanse, erfaring og forsvarlighet som bestemmer hvilke oppgaver som utføres av allmenntannlegene og hvilke oppgaver som henvises og dermed utføres av tannlegespesialister, ikke oppgavens natur. For det disse utvalgsmedlemmene kaller «allmenntannhelsetjenester», peker de på at ansvaret kan løses innenfor en fasttannlegeordning ved at kommunene enten kan ansette flere tannleger, tannpleiere og annet tannhelsepersonell eller inngå avtaler med næringsdrivende tannleger innenfor en fasttannlegeordning. Dette er diskutert helt overfladisk i utredningen. NTF er kritisk til at det pekes på en fasttannlegemodell gitt tannhelsetjenestens spesialiserte oppgaver.

Tannhelsetjenesten er, som tidligere beskrevet, en kostnadsintensiv og høyteknologisk tjeneste som i all hovedsak tilbyr avansert behandling og krever høyt kvalifisert arbeidskraft og utstyr. Tannhelsetjenesten sammenliknes derfor best med spesialisthelsetjenesten og den spesialiserte behandlingen som utføres i sykehus, i poliklinikker og hos private spesialister.

Dette er et selvstendig argument for å ikke overføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, som i liten grad har ansvaret for slike spesialiserte helsetjenester i dag.

NTF mener at det er viktig å beholde gode og robuste fagmiljøer av en viss størrelse på regionalt nivå. Følgende oppgaver vil, etter NTFs syn, være svært vanskelig å løse i den foreslåtte harmoniserte modellen:

- ha god nasjonal faglig styring på tannhelsetjenesten og et likeverdig tannhelsetilbud i hele landet
- videreføre og systematisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet
- ha ansvar for nasjonale oppgaver som utdanning, forskning og beredskap
- ha ansvar for at hele befolkningen har tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, inkl. spesialisttannhelsetjenester og andre spesialiserte tilbud som TOO⁵, behandling i narkose, lystgass m.m.
- være i stand til å rekruttere og beholde tannleger
- gjennomføre nødvendig og avgjørende opplæring og oppfølging av nytt tannhelsepersonell

NTF vil påpeke at det offentlige tannhelsetilbudet i andre nordiske land allerede er forankret i store regioner. I Sverige i länene (fylker), i Danmark i store kommuner (etter en massiv kommunesammenslåing) og i Finland i regioner. Dette kan tyde på at de andre nordiske landene har sett de samme fordelene med en regional organisering av tannhelsetjenesten som NTF her påpeker.

For NTF fremstår det som lite troverdig at en overføring av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenesten til 357 kommuner, vil «sikre en mer helhetlig styring av helse-, tannhelse- og omsorgstjenestene», «styrke målrettet forebyggende arbeid og bedre sikre pasientens rett til nødvendig hjelp fra tannhelsetjenesten, bidra til mer prinsipielt forankret prioritering, gi bedre og raskere oppfølging av pasienter med sammensatte behov og behov for spesialisert hjelp» og «styrke tjenestens ansvar for å legge til rette for forskning, utdanning og kvalitetsarbeid» (utredningen side 234).

NTF mener at flertallets vurdering av konsekvensene av forslaget ikke er forankret i dagens virkelighet i fylkeskommunene. Flertallet synes heller ikke å ha et realistisk syn på kommunenes økonomi og ressurser, eller forstå kompleksiteten av oppgavene tannhelsetjenesten utfører. Flertallets vurdering og forslag til en såkalt *harmonisert modell* fremstår følgelig som en urealistisk modell.

2.2 Regionale tannhelseforetak (fire utvalgsmedlemmer inkl. NTFs president)

NTF støtter den regionale tannhelseforetaksmodellen.

I denne modellen vil tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre overføres til tannhelsetjenesten ved de regionale tannhelseforetakene.

NTF er, på samme måte som dette utvalgets mindretall, av den oppfatning at en utvidelse av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenesten og en tilpasning til og harmonisering med den øvrige helsetjenesten, best kan oppnås med egne regionale tannhelseforetak, på linje med

⁵ Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsofsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi)

helseforetakene i dagens spesialisthelsetjeneste. NTF mener at en slik modell vil sikre en bedre nasjonal styring av tannhelsetjenesten, og at modellen vil sikre lik fordeling av tannhelsetjenester til hele befolkningen. Modellen legger godt til rette for å utnytte de samlede ressursene og kompetansen i tjenesten. Færre store enheter vil også kunne medføre økonomiske innsparinger fordi man får lavere administrasjonsutgifter.

Bakgrunnen for NTFs syn er de utfordringer vi ser i den offentlige tannhelsetjenesten som i dag er forankret i fylkeskommunene, og våre store motforestillinger mot en kommunal forankring som beskrevet i den såkalte *harmoniserte modellen*. NTF mener at en løsning med regionale tannhelseforetak vil bidra til at tannhelsetjenesten bedre integreres med resten av helse- og omsorgstjenesten, ved at den kan, så langt det er hensiktsmessig, følge de samme prinsippene for organisering, regulering og finansiering som spesialisthelsetjenesten.

NTF er av den oppfatning at antallet fremtidige regionale tannhelseforetak bør harmonere med de mål som settes for fremtidens tannhelsetjeneste, og at det bør ses hen til antall helseforetak. Erfaringen fra fylkeskommunal modell tilsier at antallet kan være noe lavere enn dagens fylkeskommuner, men at inndeling i 4 som dagens regionale helseforetak, kanskje vil gi for store regioner. Dette må utredes nærmere.

De regionale tannhelseforetakene bør ha ansvar for hele tannhelsetjenesten, og må sørge for at befolkningen får tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Dette inkluderer alle typer av spesialiserte tannhelsetjenester som utføres av tannleger med og uten spesialistkompetanse. På dette området skiller tannhelsetjenesten seg fra resten av helsetjenesten. Derfor mener NTF at tannhelseforetaket ikke bør innlemmes i helseforetakene, men ligge organisatorisk ved siden av de eksisterende helseforetakene. Dette er også en av årsakene til at NTF er svært kritisk til den såkalte harmoniserte modellen. Kommunene har i dag ikke ansvar for slike spesialiserte tjenester. Tannhelsetjenesten er en liten tjeneste, og ansvaret for en samlet tjeneste bør ligge ett sted, og ikke splittes som foreslått i den såkalte harmoniserte modellen. NTF mener at tannhelsetjenesten som en spesialisert tjeneste, i sin natur er lik de tjenestene som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

NTF anbefaler derfor at tannhelsetjenesten og dens ledelse på overordnet nivå organiseres som regionale tannhelseforetak. Slik vil staten være eier og de økonomiske rammene gis over statsbudsjettet. Staten kan styre virksomheten fra eierposisjon gjennom generalforsamling og styret. På samme måte som for spesialisthelsetjenesten kan det fastsettes overordnede helsepolitiske mål og rammer. Staten kan da ta et helhetlig ansvar for tjenestene med både myndighetsansvar, finansieringsansvar og eierskap. Dette vil sikre en bedre nasjonal styring og gi god mulighet for planlegging og dimensjonering av tjenesten. Det vil også kunne legge grunnlaget for et mer enhetlig og likeverdig tannhelsetilbud i hele landet og sikre en faglig styring av tjenesten samt at pengene som bevilges til tannhelsetjenesten brukes i tannhelsetjenesten. Modellen gir gode forutsetninger for å bidra til en bedre samordning av den samlede offentlige finansieringen på tannhelsefeltet, og sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet til hele befolkningen. Modellen vil også bidra til å sikre en bedre regional fordeling av de samlede tannhelsepersonellressursene.

De regionale tannhelseforetakene bør overta de regionale odontologiske kompetansesentrenes oppgaver. De kan tilpasse behovet i sin region, og i en slik modell kan man bedre legge til rette for samarbeid og samhandling rundt ulike nasjonale oppgaver. De regionale tannhelseforetakene bør i tillegg til å ha ansvar for tannhelsetjenester til hele befolkningen og ansvar for nasjonale oppgaver som beredskap, helsefremmende og forebyggende arbeid, i samarbeid med helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet. Videre bør de ha ansvar for kompetanseheving i hele tannhelsetjenesten, og kompetanseheving og opplæring av helsepersonell i andre helsetjenester. De bør bidra til forskning og utdanning av alt

tannhelsepersonell, og modellen legger til rette for et bedre samarbeid med de odontologiske lærestedene om disse oppgavene, som lærestedene jo har ansvar for.

Tannhelseforetakene skal ha det overordnede ansvaret for at hele befolkningen har tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, inkludert spesialisttannhelsetjenester. Det betyr ikke at alle tjenestene kan eller skal ytes av tannhelseforetakene selv. Tannhelseforetakene vil selv kunne bestemme hvor mange tannklinikker de vil ha i sin region ut ifra hvilke tjenester de vil levere selv, med egne ansatte. Det kan eksempelvis være behov for å levere spesialiserte tannhelsetjenester til sårbare grupper, narkosebehandling, tverrfaglig spesialisert tannbehandling, behandling av pasienter med komplekse odontologiske utfordringer og lignende.

Nødvendige tannhelsetjenester som det ikke er hensiktsmessig, eller nødvendig, at tannhelseforetaket leverer kan med fordel fortsatt leveres av privat tannhelsetjeneste, etter avtale med tannhelseforetaket. Dette kan tilpasses den enkelte region og befolkningens behov for tjenester. Denne modellen legger derfor til rette for en effektiv universell tannhelsetjeneste hvor alle ressurser og all kompetanse i hele tjenesten utnyttes på best mulig måte. En foretaksorganisering vil kunne bidra til bedre samhandling, samarbeid og koordinering mellom offentlig og private tannhelsetjenestetilbydere, til en samlet bedre utnyttelse av ressursene i hele tannhelsetjenesten og til et mer enhetlig tilbud til pasientene. Modellen vil bidra til bedre målretting av de samlede offentlige ressursene som brukes på tannhelsetjenester. Denne modellen vil dermed kunne bidra til å utjevne sosial ulikhet i munnhelse.

Det må utredes hvordan overføringen av de eksisterende fylkeskommunale tannklinikkene og de regionale odontologiske kompetansesentrene kan gjennomføres, og det må sikres at tannhelsepersonellens lønns- og arbeidsvilkår ivaretas på en best mulig måte

Tannhelseforetakene bør inngå forpliktende samarbeidsavtaler med resten av helsetjenesten. Ute på tannklinikkene, både offentlige og private, bør det legges til rette for utstrakt samarbeid mellom tannhelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten og andre tjenester i kommunene, via samarbeidsavtaler. Tannpleiere kan gjennomføre enkle undersøkelser på institusjoner og på helsestasjoner, ha ansvar for opplæring av helsepersonell og befolkningen, samt annet helsefremmende og forebyggende arbeid.

Det individuelle forebyggende arbeidet vil fortsatt ivaretas av tannhelsepersonellet i forbindelse med behandling av den enkelte pasient.

Tannhelseforetakene vil, på bakgrunn av det helhetlige ansvaret og inngåelse av avtaler med private tjenesteytere, få oversikt, kunne stille krav og ha mulighet til å føre tilsyn med tjenesten på en annen måte enn fylkeskommunene har i dag. Dette vil bidra til ytterligere kvalitetsforbedring, god pasientsikkerhet og mer likhet i tjenesten. Tannhelseforetakene bør inngå avtaler med det enkelte helsepersonell. Dette vil legge til rette for at det fortsatt kan drives lokale, tannlege-eide virksomheter i regionen som leverer tannhelsetjenester etter avtale med tannhelseforetaket. I en slik modell vil det være mindre behov i tjenesten for konsolidering og dannelse av større virksomheter. Modellen med avtaler mellom det offentlige og private tjenesteytere er utbredt på spesialisthelsetjenestenivå, og et tannhelseforetak vil ha bedre forutsetninger og (bestiller-) kompetanse til å inngå slike avtaler enn hva kommunen/fylkeskommunen har.

Tannhelseforetakene vil dessuten kunne ta et overordnet ansvar for fagutvikling og utvikling av faglige standarder, i samarbeid med resten av tjenesten, utdanningsinstitusjonene og myndighetene.

Oppsummert mener NTF at denne modellen innebærer en harmonisering og integrering med resten av helsetjenesten, og at modellen legger til rette for bedre samhandling. Modellen

muliggjør bedre nasjonal styring av tannhelsetjenesten. I tillegg vil modellen legge til rette for mer direkte faglig styring, og sikre mulighet for bedre ressursutnyttelse i hele tannhelsetjenesten ved økt samarbeid mellom den offentlige og private delen av tannhelsetjenesten. Modellen legger til rette for lokale tilpasninger for å sikre et godt tannhelsetilbud over hele landet. I spredtbygde områder vil tannhelseforetakene kunne tilby tjenester til innbyggerne med en velutbygd klinikkstruktur, som også dekker områder der det ikke er grunnlag for etablering av et privat tannhelsetilbud. I områder med mange private tannleger kan befolkningens behov dekkes gjennom avtaler mellom de private tilbyderne og tannhelseforetakene om å levere nødvendige offentlig finansierte tannhelsetjenester. På den måten utnytter man de samlede ressursene og kompetansen i tannhelsetjenesten på en god og kostnadseffektiv måte og i henhold til offentlige prioriteringer. En betydelig fordel ved etableringen av regionale foretak vil også være direkte statlig finansiering, i motsetning til dagens praksis med rammeoverføringer til fylkeskommunene som det har vist seg at ikke alltid tilfaller tannhelsetjenesten.

2.3 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (to utvalgsmedlemmer)

NTF støtter ikke denne modellen, og mener som flertallet i utvalget at ansvaret for den offentlig finansierte tannhelsetjenesten må flyttes ut av fylkeskommunen.

NTF vil likevel understreke at den harmoniserte modellen er det dårligste alternativet, da hele tannhelsetjenesten må være tilknyttet et regionalt nivå, og under ingen omstendighet må splittes mellom kommunene og de regionale helseforetakene.

Et lite mindretall på 2 personer i utvalget ønsker å videreføre fylkeskommunen som ansvarlig forvaltningsnivå for organisering av den offentlig finansierte tannhelsetjenesten. De mener at fylkeskommunen har god kontakt med kommunene og statlige myndigheter, at de ivaretar tverrfagligheten i tannhelsetjenesten og sørger for tilgjengelige tannhelsetjenester i sin region. Mindretallet mener derfor at rammene for å styrke og videreutvikle fylkeskommunenes samlede ansvar for den offentlig finansierte tannhelsetjenesten er godt til stede.

I denne modellen vil tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre overføres til den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunen.

NTF er kritiske til denne modellen. Den offentlige tannhelsetjenesten utgjør om lag 14% av fylkeskommunenes virksomhet i dag og er den eneste helsetjenesten fylkeskommunene har ansvar for. Samhandling og samarbeid med resten av helsetjenesten er i dag svært krevende. Fylkeskommunen har stor valgfrihet med hensyn til organisasjonsmodell for den offentlige tannhelsetjenesten. I etterkant av regionreformen har fylkeskommunene valgt å organisere tjenesten på forskjellige nivåer og på vidt forskjellig vis; noen sammen med videregående opplæring, andre med næring eller folkehelse. Dette skaper ulike utfordringer og medfører at fylkene har svært ulike tilbud til befolkningen i de ulike delene av landet. Det fremkommer tydelig i rapporten *Kartlegging av organisering og finansiering av den offentlige tannhelsetjenesten* utarbeidet av Oslo Economics på vegne av NTF i november 2024⁶.

NTF mener at denne modellen ikke vil bidra til en harmonisering med resten av helsetjenesten. Den bidrar heller ikke til å løse de utfordringene vi ser i dagens tannhelsetjeneste.

⁶ En presentasjon av rapporten finnes tilgjengelig her:

<https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.512026e71942f6441345fa5e/1736347496095/Oslo%20Economics%20-%20Kartlegging%20av%20organisering%20og%20finansiering%20av%20DOT.pdf>

Tannhelsetjenesten finansieres gjennom rammeoverføringer til fylkeskommunene, og budsjettet blir vedtatt i fylkestinget. DOT er i dag underfinansiert og har ikke nok midler til å utføre sine lovpålagte oppgaver. DOT har også flere steder utfordringer med å rekruttere og beholde tannhelsepersonell. Vi ser at penger som bevilges av Stortinget til tannhelsetjenester ikke nødvendigvis tilfaller den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene, men brukes til andre formål. Det er en stor svakhet med denne modellen.

3 Rammer og reguleringer for privat sektor

Tannhelseutvalget kommer med flere forslag som de mener vil tydeliggjøre rammene for utøvelse av privat tannhelsevirksomhet for å sikre at privat tannhelsevirksomhet utføres i tråd med myndighetenes målsettinger. Utvalget mener dessuten at det er viktig å følge med på den utviklingen som skjer i det private markedet, fra selvstendige og tannlegeeide klinikker til et marked med økende eierskap av investor-eide kjeder.

NTF vil understreke at den private tannhelsetjenesten i dag er en viktig del av tannhelsetjenesten og leverer tjenester av høy kvalitet til størstedelen av den voksne befolkningen. NTF støtter derfor at det er viktig med tydelige og forutsigbare rammer for privat tannhelsetjeneste. Vi har i lang tid påpekt at endringene i privat tannhelsetjeneste, med konsolidering og store investor-eide virksomheter som kjøper opp tannklinikker, kan få konsekvenser for den faglige styringen av tjenesten, og at dette kan påvirke den faglige autonomien til tannleger. NTF er også kjent med at det blir mer og mer vanlig at det settes omsetningskrav i enkelte deler av tjenesten. Dette kan sette faglig autonomi og etikk under press, og tannhelsepersonellet må skjermes og beskyttes mot dette. NTF mener derfor at det er viktig at myndighetene har god oversikt over den private tannhelsetjenesten, og at det løpende sikres at hele tannhelsetjenesten drives og ledes i tråd med eksisterende lovverk og retningslinjer. NTF er positive til at det nå legges til rette for at det kan hentes inn bedre data både fra offentlig og privat tannhelsetjeneste.

NTF har i lang tid anbefalt at myndighetene sikres en bedre oversikt over alt helsepersonell som faktisk arbeider i helse- og omsorgstjenesten. Det finnes et eget register over alle som har autorisasjon eller lisens, men det fremgår ikke av dette registeret hvem som arbeider i Norge eller hvor de arbeider. Det viste seg å være et stort problem under pandemien at myndighetene ikke hadde oversikt over tannhelsepersonell eller mulighet til å kommunisere med dem.

For å lykkes med en innføring av en universell tannhelsetjeneste er det avgjørende at det legges til rette for et fortsatt godt samarbeid mellom den offentlige delen av tannhelsetjenesten og den private tannhelsetjenesten. Den private tannhelsetjenesten består av klinikker i ulike størrelser, kontorfellesskap og kjeder, allmenntannleger og ulike spesialiteter. Felles for alle er at det er gjort store økonomiske investeringer for å etablere eller overta virksomhetene. Privat tannhelsetjeneste er helprivat. Det vil si at tjenesten ikke får tilskudd til etablering eller drift og det er fri etablering og fri prissetting i den private delen av tannhelsetjenesten.

Forutsigbarhet og gode rammevilkår er viktige faktorer for de som leverer private helsetjenester, inkludert tannhelsetjenester. Det er derfor også en forutsetning for at en universell tannhelsetjeneste skal lykkes at tilstrekkelig finansiering er sikret, også med tanke på kostnadsutvikling over tid.

Befolkningen har stor tillit til privat tannhelsetjeneste i dag, og befolkningen er fornøyd med de tjenestene som leveres. Det viser blant annet en undersøkelse fra EPSI utført i 2024 hvor privat tannhelsetjeneste igjen ligger på toppen av lista med en kundetilfredshet på over 80. EPSI

skriver at tannlegene leverer tjenester på et svært høyt nivå og innfrir kundenes forventninger⁷. Det er over tid gjort store investeringer i utstyr og kompetanse i tannhelsetjenesten, og tjenesten leverer spesialisert behandling av høy kvalitet. NTF vil understreke at økt offentlig finansiering ikke må innebære føringer eller reguleringer som vil føre til forringelse av kvaliteten på behandlingen som blir levert i tjenesten.

Oslo Economics anslår i rapporten *Kartlegging av den private tannhelsetjenesten* at det er 3 700 private tannleger som behandler 3,7 millioner pasienter årlig, fordelt på 1 700 tannlegepraksiser. Den private tannhelsetjenesten bidrar vesentlig til verdiskaping i samfunnet og ulike typer praksiser har ulikt skattebidrag. De estimerer omsetningen i den private tannhelsetjenesten til 13,6 milliarder kroner og skattebidraget til 2,55 milliarder kroner i 2022.⁸ Til sammenligning utgjorde de totale utgiftene til DOT 3,4 milliarder kroner og folketrygdens utgifter til tannhelsetjenester 2,5 milliarder kroner samme år (SSB tabell 10811).

Solopraksiser og små praksiser står for de største delene av omsetningen i den private tannhelsetjenesten, noe som henger sammen med at det er mange av denne typen praksiser. Kjedene er få, men store, og står for den tredje største andelen av omsetningen. Assistenttannleger, som er selvstendig næringsdrivende tannleger som arbeider i virksomheter eid av andre med ulike avtaler (leietannleger eller kontraktører), utgjør den fjerde største gruppen, etterfulgt av større praksiser. Det høyeste forholdstallet mellom skattebidrag og omsetning finner vi for solopraksiser, som dermed har størst skattebidrag relativt til omsetning. De store kjedene har lavest skattebidrag relativt til omsetning.

I tillegg til omsetning og skattebidrag, er tannhelsetjenesten kapitalkrevende, og det er foretatt store investeringer i behandlingsrom og utstyr. Totale initiale investeringer er estimert til 10 milliarder kroner. Dette estimatet er et anslag på kostnaden ved å etablere det antall behandlingsrom som eksisterer i dag i privat tannhelsetjeneste. Kostnaden ved å etablere et behandlingsrom anslås til å være relativt lik for både store og små praksiser.

NTF mener at i en universell tannhelsetjeneste må ulike finansieringsordninger utredes nærmere, og man bør se til de ulike ordningene og avtalene som finnes i resten av helsetjenesten. Det er avgjørende at det etableres ordninger hvor ressursene og kompetansen i privat tannhelsetjeneste utnyttes på best mulig måte, selv om det offentlige skal ha et overordnet ansvar for finansiering av tjenesten.

For å sikre rammevilkår som også ivaretar små og mellomstore tannlegevirksomheter, er det viktig at finansiering følger pasienten slik at disse selv kan velge behandler. Privat tannhelsetjeneste må kunne behandle pasienter med rett på offentlig finansiering for nødvendige tannhelsetjenester. Det bør lages avtaler mellom den enkelte tannlege og det offentlige, for å sikre faglig styring av tjenesten. NTF mener at det er viktig at tannleger selv eier virksomhetene i tjenesten, og at det i en fremtidig modell må legges til rette for dette. NTF mener at krav til eierskap kan reguleres i lovverk, slik det gjøres i andre yrker der faglig autonomi er viktig, som for eksempel for advokater. NTF er svært kritiske til en eventuell anbudsmodell fordi en slik modell vil favorisere de største investor-eide virksomhetene/kjedene.

Tannhelsetjenesten er en kostnadsintensiv tjeneste hvor det utføres spesialisert og avansert behandling, og tjenesten har mye til felles med poliklinikker og små sykehus. Det tas røntgenbilder, settes anestesi og gjøres kirurgiske inngrep daglig på de fleste tannklinikker, og alle tannklinikker har sterilrom med avansert utstyr. Tjenesten drives fra klinikker, ikke kontorer.

⁷ www.epsi-norway.org/wp-content/uploads/2025/03/epsi-norge-kundetilfredshetsaret-2024.pdf

⁸

www.tannlegeforeningen.no/download/18.7add97c51900c61ec176d068/1736347563937/Oslo%20Economics%20-%20Kartlegging%20av%20den%20private%20tannhelsetjenesten.pdf

NTF vil understreke at myndighetene må ta ansvar for finansiering av tiltak som skal bidra til å styrke arbeid med kvalitet, pasientsikkerhet og digitalisering i tannhelsetjenesten. Utvalget synes å legge til grunn at svært mange av forslagene skal finansieres av privat tannhelsetjeneste selv. I en universell tannhelsetjeneste der myndighetene påtar seg ansvaret for å finansiere tjenesten, gir det ikke mening at slike tiltak skal dekkes av privat tannhelsetjeneste. Slik dagens modell er, verken kan eller vil NTF støtte en ordning som først påtvinges en helprivat tjeneste, for deretter å avkreve finansiering av aktørene i tjenesten.

3.1 Om prisregulering

Forslag 11 A. Innføre prisregulering ved offentlig finansiering av tannhelsetjenester og utrede hvordan en slik regulering bør utformes

NTF støtter ikke forslag 11 A.

NTF forstår behovet for å utrede en eventuell prisregulering for nødvendige tannhelsetjenester hvis disse tjenestene i hovedsak skal finansieres av det offentlige. NTF vil på det sterkeste understreke at før en eventuell prisregulering innføres må både innretting og konsekvenser av slik regulering utredes. Utredningen må omhandle situasjonen både ved en trinnvis og umiddelbar innføring av en universell ordning.

Forslag 11 B. Utrede prisregulering for tannhelsetjenester ved utvidelse av offentlig finansiering

NTF støtter forslag 11 B.

NTF har forståelse for at det er behov for å utrede og innføre prisreguleringer dersom tjenestene i hovedsak er offentlig finansiert. Imidlertid må både behovet for, effektene av og innretningen av prisregulering utredes før den vedtas innført. Så lenge den offentlige finansieringen ikke er fullstendig eller tjenestene i hovedsak er offentlig finansiert kan NTF ikke støtte en prisregulering. Helprivate tannhelsetjenester må behandles som andre helprivate helsetjenester.

Dersom det innføres prisregulering, må det etableres modeller der denne følger samfunnets og bransjens generelle pris- og kostnadsøkning. Prisene må være reelle og gjenspeile kostnadsnivået i bransjen. Prisene må jevnlig reguleres og forhandles om slik det gjøres for resten av helsetjenesten der profesjonsforeningene også er part i forhandlingene. Hvis man skulle velge å innføre prisregulering i tannhelsetjenesten, for tannhelsetjenester som er fullt ut eller hovedsakelig offentlig finansiert, må NTF være en slik part i forhandlinger. Tjenesten har erfaring fra tidligere ordning med honorartariff hvor disse forutsetningene ikke var på plass. Det medførte en tannhelsetjeneste som ikke kunne investere i klinikker, utstyr eller kompetanseheving og at det var svært krevende å levere tannhelsetjenester av god kvalitet til befolkningen.

Det er viktig for NTF at kvaliteten på den tannbehandling som utføres er god og at tannlegene har mulighet til å utøve faglig autonomi og mulighet til å påvirke valg av behandling, materiale, utstyr og bruk av norskprodusert tannteknikk. Det siste er viktig også i beredskapsøyemed, og i

forhold til bærekraft. Det er dessuten avgjørende at tannhelsetjenesten kan investere i nødvendig utstyr og kompetanseheving slik at man sikrer utvikling og innovasjon i tjenesten.

NTF vil understreke at en underfinansiering vil være ødeleggende for en universell tannhelsemodell. I en slik modell må det sikres gode rammebetingelse for hele tannhelsetjenesten, slik at også privat tannhelsetjeneste vil bidra, ellers vil man ikke klare å sikre befolkningen rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

3.2 Om prisportal

Forslag 12. Videreutvikle og gjenåpne prisportal for tannhelsetjenester ved innhenting av priser via Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

NTF støtter ikke forslag 12.

NTF mener at en gjenåpning av prisportalen ikke er hensiktsmessig. Prisportalen fungerte ikke etter hensikten da den ble åpnet, og den ga ikke god prisinformasjon til pasientene. NTF mener at behovet for prisopplysninger dekkes av prisopplysningsforskriften, og at denne eventuelt kan presiseres og håndheves i større grad. Tannhelsetjenester er ikke en vare, men en tjeneste, og en prisportal er derfor lite egnet. Riktig pris og behandlingsforslag kan først gis etter en individuell vurdering av den enkelte pasient. Det bemerkes også at i en universell ordning med offentlig finansiering av nødvendig tannhelsetjenester vil behovet for prisportal heller ikke være til stede. Prisportal er heller ikke relevant i en ordning med avtaler mellom tannleger og den offentlige tannhelsetjenesten som regulerer pris.

NTF mener at det er viktig at befolkningen har god forståelse for sine rettigheter og kunnskap om tannhelsetjenester. Økt helsekompetanse er viktig og her finnes gode kanaler som helsenorge.no som bør styrkes.

NTF vil også bemerke at hvis tanken er at en helprivat tannhelsetjeneste skal pålegges rapportering til en slik løsning, må myndigheten selv bære kostnaden for en slik tjeneste. NTF mener at det ikke er riktig å hente inn priser til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dette er et register som ikke er opprettet med formål om å gi kunnskap om eller regulere prisen i en helsetjeneste.

3.3 Om plikt til å informere om klagemuligheter

Forslag 27. Utarbeide retningslinjer for tannhelsetjenestens plikt til å informere om klagemuligheter etter behandling.

NTF støtter dette forslaget.

Det er vanskelig for pasientene å orientere seg om rettigheter i dagens tannhelsetjeneste. Det er også krevende for behandlerne at lovverket er så komplisert. Dette er et viktig tiltak for økt pasientsikkerhet, og det vil også lette belastningen på den enkelte behandler. Myndighetene bør også sikre god pasientinformasjon for eksempel på helsenorge.no.

3.4 Om styrking av dagens tilsynsordninger

Forslag 28. Utrede om det er behov for å styrke tilsynet med tannhelsetjenesten.

NTF støtter dette forslaget.

NTF mener at en styrking av dagens tilsynsordninger, slik at tilsynsmyndighetene blir i stand til å utøve sitt tilsyn, vil være et godt alternativ til innføring av egne konsesjonsordninger for tannhelsetjenester og vilkår knyttet til disse. NTF har i lang tid vært bekymret for at det føres lite tilsyn med tannhelsetjenesten. Det må sikres at Helsetilsynet settes i stand til å utføre denne oppgaven på en god måte. NTF ser ikke behov for nye tilsynsordninger, men det må legges til rette for at tilsynsmyndighetene utfører tilsyn i tråd med dagens regelverk.

Forslag 36. Styrke tilsyn med private tannhelsetilbydere for å sikre etterlevelse i henhold til rammene for utøvelse av privat virksomhet

NTF støtter dette forslaget.

NTF mener at myndighetene bør ha bedre kunnskap og oversikt også over den private tannhelsetjenesten. Den private tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten, og det er viktig at det føres tilsyn slik at det sikres at det leveres tjenester av høy kvalitet og at pasientsikkerheten er godt ivaretatt i hele tannhelsetjenesten. NTF har ingen grunn til å tro at det ikke er tilfelle, men vi får fra tid til annen henvendelser om tannklinikker som ikke følger lovverket.

I en modell hvor alle har tilgang til nødvendig tannbehandling er det avgjørende å utnytte ressursene og kompetansen i hele tannhelsetjenesten. Da vil det være nødvendig med bedre innsikt og oversikt over privat tannhelsetjeneste enn det vi har i dag.

3.5 Om konsesjonsordninger

NTF vil understreke at det virker uhensiktsmessig å innføre særegne konsesjonsordninger som skal gjelde spesielt for tannhelsetjenesten, og ikke for andre tilbydere av helsetjenester, særlig når målet er en harmonisering mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten.

Det er fra utvalgets medlemmer blant annet vist til kvalitetssikring som begrunnelse for foreslåtte konsesjonsordninger. Det bemerkes til dette at det allerede i dag er en rekke lov- og forskriftsfestede krav for å sikre kvalitet og forsvarlighet for helsetjenester, og NTF kjenner heller ikke til at det finnes tall eller undersøkelser som tyder på at den faglige kvaliteten på tjenestene som utføres i dag er dårlig. NTF støtter likevel ulike tiltak som vil kunne bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, som for eksempel innsamling av data og et register over tilgjengelig helsepersonell. NTF mener at det er bedre å styrke dagens ordninger og sikre bedre tilsyn med disse, enn å innføre egne konsesjonsordninger for tannhelsetjenesten. Det er heller ikke sannsynliggjort at ordningene utvalget anbefaler vil løse de utfordringene utvalget selv peker på.

NTF bemerker at forslagene om konsesjoner ikke er utredet. NTF mener at det vil være uansvarlig å innføre slike ordninger uten en grundig utredning. NTF mener dessuten at konsesjonsordningene, slik de er beskrevet, ikke vil føre til økt kvalitet i tjenesten eller løse noen av de andre utfordringene tannhelseutvalget peker på, blant annet konsolidering i tjenesten

med store investor-eide virksomheter og manglende kontroll med tjenesten. Kravene til eiere og vilkår som er beskrevet vil derimot, slik NTF ser det, gi større virksomheter og kjeder en fordel fremfor de små og mellomstore klinikkene.

Tannhelsetjenesten og helsetjenesten er i dag underlagt tilsyn, og en rekke lover og reguleringer som er med på å sikre kvalitet og kontroll med tjenesten. NTF mener at økt offentlig finansiering og innføring av universell tannhelsetjenestdekning vil styrke ytterligere kontroll og heving av kvalitet i tjenesten.

NTF mener at det er svært viktig å sikre og styrke den tannhelsefaglige styringen av tjenesten, og å stille faglige krav til drift og behandling, som for eksempel språkkrav. Dette kan gjøres i eksisterende lovverk og i samarbeidsavtaler, som i resten av helsetjenesten. Bruk av slike avtaler må eventuelt utredes og de bør være i henhold til avtaler som finnes i resten av helsetjenesten (avtaler som regulerer pris, kvalitet, plikter og rettigheter).

Forslagene underbygger heller ikke målet om en harmonisering og integrering mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten, da det som foreslås er særordninger for tannhelsetjenesten, noe som ikke bidrar til en likestilling og harmonisering av tjenestene, men heller undergraver den. NTF vil understreke at disse ordningene vil være overflødige hvis den offentlige finansieringen økes og tannhelsetjenesten harmoniseres med resten av helsetjenesten.

Forslag 37. Innføre lovfestede krav for private tannhelsetilbydere om å søke konsesjoner for klinikkdrift

NTF støtter ikke dette forslaget.

Det gir lite mening å innføre egne konsesjonsordninger med særlige vilkår når et av de uttalte målene er at tannhelse skal bli mer som resten av helsetjenesten. NTF mener at forslagene om konsesjon er dårlig utredet og det er ikke synliggjort hvilke utfordringer de foreslåtte konsesjonsordningene og de foreslåtte vilkårene er ment å løse.

Til forslaget om konsesjon for klinikkdrift er det blant annet nevnt vilkår knyttet til tilstedeværelse av faglig ansvarlig person som er fysisk tilgjengelig. NTF bemerker til dette at alle tannleger er faglig ansvarlige for eget arbeid og for arbeid som utføres av hjelpepersonell uten egen autorisasjon som helsepersonell. Det er også etter dagens lovgivning et krav om tilstedeværelse av tannlege/tannpleier der det ytes helsehjelp som krever slike autorisasjoner.

Det er også nevnt at det kan stilles språkkrav, men dette er imidlertid et krav som allerede gjelder. Klinik-konsesjonæren skal også være ansvarlig for at den daglige drift er i tråd med faglige krav som stilles i lovverket, medvirke under tilsyn og sørge for rapporteringer. NTF mener at dette ivaretas i dagens lovverk. Det skal også kunne stilles krav om at alle nødvendige tannhelsetjenester skal kunne tilbys og det skal rapporteres på personell. I sum vil disse nye elementene være enklere å oppfylle for store virksomheter og kjeder, og det vil kunne føre til utfordringer for de små og mellomstore tannlegeeide virksomhetene og på sikt føre til enda større konsolidering i tjenesten.

Forslag 38. Innføre et lovfestede krav for private tannhelsetilbydere om å søke konsesjoner for eierskap av tannklinikker

NTF støtter ikke dette forslaget.

Noen av vilkårene under forslag 38 er at det skal opplyses om hvordan klinikken skal drives og finansieres, og at det kan stilles krav om at økonomiske rammevilkår må dokumenteres. Det skal videre stilles krav om dokumentasjon på tilstrekkelig faglig omfang. Det vil etter NTFs syn være tilnærmet umulig å starte egen tannlegevirksomhet for tannleger i fremtiden dersom det skal stilles slike vilkår. Videre vil dette favorisere de store virksomhetene fremfor de små og mellomstore tannlege-eide virksomhetene.

Forslagene om konsesjon legger videre til grunn at ordningen skal forvaltes av Helfo, alternativt Direktoratet for medisinske produkter, uten at det er vurdert eller tilkjennegitt hvorfor disse er rette forvaltningsorgan. NTF vil understreke at disse oppgavene ikke passer inn i disse organenes oppgaver eller ansvar i dag, og syns det er unaturlig at disse oppgavene skal legges til disse forvaltningsorganene.

NTF er av den oppfatning at det blir helt avgjørende å sørge for at det fremover legges bedre til rette for at tannleger kan eie og drive små og mellomstore tannlegevirksomheter, for fortsatt å sikre gode tannhelsetjenester til befolkningen i hele landet. Begge disse konsesjonsordningene vil etter vårt syn, bidra til det stikk motsatte. NTF vil derfor advare på det sterkeste mot at slike konsesjonsordninger innføres.

4 En universell tannhelsetjeneste - trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret

I kapittel 14 *En universell tannhelsetjeneste – trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret* vurderer Tannhelseutvalget hvordan en trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester kan gjennomføres. Tannhelseutvalget anbefaler det **pragmatiske alternativet** som er beskrevet ved at stadig flere tjenester inkluderes i det offentlige ansvaret og flere grupper får rett til offentlig finansierte tjenester over tid. NTF støtter ikke dette.

NTF støtter en **prinsipiell tilnærming** hvor man innfører en universell ordning med en gang.

Innføring av en universell rett og tilgang til nødvendig tannhelsehjelp, på linje med annen helsehjelp, innebærer en stor endring fra dagens situasjon. NTF forstår hvorfor utvalget har landet på å anbefale en pragmatisk tilnærming i den trinnvise utvidelsen, men NTF er skeptiske denne tilnærmingen da vi anser det for å være en stor fare for at man da ikke vil fullføre utvidelsen av en komplett universell modell. Erfaringsmessig har endringer i tannhelsetjenesten vært stykkevis og delt, og preget av politiske vedtak uten faglig forankring. I en trinnvis modell er det fare for at man bare velger noen av trinnene og så sier seg fornøyd med det. En slik trinnvis utvidelse vil sannsynligvis også kreve mer administrasjon og kontroll som vil medføre større utgifter.

NTF mener at det nå er viktig at hele befolkningen får rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Vi mener derfor at det riktige er en prinsipiell tilnærming hvor man innfører en universell rettighet til nødvendig tannbehandling. Størrelsen på stønaden reguleres slik at egenbetalingen til pasientene graderes. Egenandelene kan så senkes når den offentlige finansieringen utvides.

Et stort mindretall av seks utvalgsmedlemmer, inkludert NTFs president, har ikke ønsket å ha alderskohorter som grunnlagskriterier for særskilt stønad i en trinnvis tilnærming mot universell finansiering, noe NTF støtter.

DEL IV - NTFs INNSPILL TIL KAPITTEL 12

UTVALGETS VURDERINGER AV DAGENS

TANNHELSETJENESTE

I kapittel 12 gjør utvalget rede for hvilke vurderinger som ligger til grunn for utvalgets forslag og de påpeker at det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om befolkningens tannhelse, tjenestenes kvalitet og utgifter til tannbehandling samt utviklingen i tjenestetilbudet.

NTF vil i det følgende kommentere utvalgets vurderinger.

12.1 Behov for en universell tannhelsetjeneste

NTF stiller seg bak Tannhelseutvalgets vurderinger om at tannhelsehjelp bør omfattes av rett til nødvendig helsehjelp, på samme måte som for andre helse- og omsorgstjenester, og at målet er en universell tannhelseordning hvor alle har rett til nødvendig tannhelsehjelp.

Tannhelsetjenesten er i dag ikke integrert med resten av helsetjenesten, og man har ikke et godt nok samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste. Det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester bør utvides.

12.2 Tannhelsen i befolkningen blir stadig bedre

NTF vil understreke at selv om tann- og munnhelsen hos den norske befolkningen i hovedsak er god, rammes fortsatt mange av sykdommer i munnhulen og om lag halve Norges befolkning har helsetap som følge av slike sykdommer og lyter. Folkehelseinstituttets sykdomsbyrdestudie presenterer data for de viktigste årsakene til helsetap i Norge og i 2021 var orale sykdommer på åttende plass⁹.

En kunnskapsoppsummering fra Helsedirektoratet viser at det er klare assosiasjoner mellom munnhulesykdommer og somatiske og psykiske sykdommer.

Karies og periodontitt er fortsatt utbredte sykdommer som krever fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Erosjonsskader blant unge øker og krever ytterligere oppmerksomhet og tiltak. Sosioøkonomiske faktorer spiller en betydelig rolle, hvor personer med lav inntekt og utdanning har høyere risiko for dårlig munnhelse og lavere bruk av tannhelsetjenester. NTF vil understreke at vi har spesielt lite kunnskap om munnhelsen til sårbare og utsatte grupper, da disse menneskene er i liten grad representert i befolkningsstudier. Disse gruppene har ofte et betydelig behov for tannhelsetjenester, og den begrensede kunnskapen gir oss et ufullstendig bilde av tannhelsetilstanden i befolkningen.

NTF vil dessuten påpeke at når befolkningen nå i større grad beholder tenner livet ut vil dette, kombinert med stadig økende levealder, gi et økt behov for tannhelsetjenester. Dette er spesielt relevant for en aldrende befolkning, som har høyere risiko for kroniske sykdommer som demens, diabetes og hjerte- og karsykdommer, som alle sykdommer som er nært knyttet til dårlig munnhelse. En aldrende befolkning vil kreve mer avanserte tannhelsetjenester.

Det er viktig å understreke at det at flertallet har lave utgifter til tannlege ikke nødvendigvis betyr at behovet for tannhelsetjenester er lite. Disse undersøkelsene tar ikke høyde for at de spurte

⁹ <https://www.fhi.no/he/senter-sykdomsbyrde/sykdomsbyrde-i-norge/>

kan ha et større behov for tannbehandling enn det de har fått utført, men at de av ulike årsaker, som økonomi, har avstått fra nødvendig behandling eller valgt rimeligere behandling enn det anbefalte.

Det er en høyere andel av befolkningen i Norge som oppgir å ha et udekket behov for tannhelsetjenester, enn gjennomsnittet i EU. Økonomi oppgis som den vanligste årsaken til udekket behov for tannhelsetjenester. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå unnlater så mange som 329.000 nordmenn hvert år å gå til tannlegen på grunn av økonomiske utfordringer. Dette er etter NTFs oppfatning uakseptabelt.

12.3 Geografisk tilgjengelighet

NTF mener at det er avgjørende med god tilgang til tannhelsetjenester i hele landet, og det er i hovedsak god geografisk tilgang til tannhelsetjenester i dag. NTF vil påpeke at man i dag ikke utnytter kompetansen og ressursene i hele tannhelsetjenesten godt nok for å sikre god tilgang til tannhelsetjenester for hele befolkningen. Organiseringen av fremtidens tannhelsetjeneste må legge til rette for et bedre samarbeid mellom den offentlige og den private tannhelsetjenesten enn i dag, og det bør ses på hvordan oppgavefordelingen bør være for å utnytte ressursene på best mulig måte. I dag fungerer ikke dette samarbeidet optimalt, og vi utnytter ikke ressursene i den samlede tannhelsetjenesten på en god nok måte.

NTF mener at det har vært positivt for tannhelsetjenesten og pasientene at tannlegene selv har eid og drevet sine egne virksomheter. Dette har ført til en god geografisk tilgang til tannhelsetjenester, også i perifere strøk, og det har bygget opp under tannlege-pasientrelasjonen. Dette bekreftes også i ulike omdømmeundersøkelser.

Tannhelseutvalget peker på at de store investor-eide kjedene vokser i omfang, og at de vokser mest i sentrale strøk. Dette vil på sikt føre til en større sentralisering av tannhelsetjenester og dårligere geografisk spredning. En slik kjededannelse vil også kunne ha andre konsekvenser som mindre faglig styring og mer press på økonomisk inntjening. En innretning med større klinikker med mange behandlere kan svekke tannlege-pasientrelasjonen fordi det ikke nødvendigvis legges til rette for at pasienten følges opp av den samme tannlegen. Det er ikke en heldig utvikling slik NTF ser det.

Oslo Economics skriver i en rapport utarbeidet for NTF i 2024; *Kartlegging av den private tannhelsetjenesten*, at det i tillegg til fremveksten av gruppepraksiser, også foregår konsolidering og kommersialisering i markedet. Praksiser blir større, og stadig flere tannleger velger å tilknyttes en kjede. De skriver videre at det er mange fordeler ved konsolidering; som muligheter til å utnytte seg av stordriftsfordeler, større fagmiljøer og bedremuligheter for investeringer. De skriver at dette kan bidra til lavere priser og bedre kvalitet på tjenestene til pasientene. Analysen Vista Analyse har utført for Tannhelseutvalget viser derimot at kjedene i gjennomsnitt har 10 % høyere priser enn andre virksomheter.

Samtidig peker Oslo Economics i sin rapport på at konsolidering kan innebære mindre fleksibilitet og autonomi for tannlegene, samt økt risiko for at pasienter ikke følges opp av samme tannlege over tid. Endring i eierstrukturen til praksisene, som innebærer færre tannleger på eiersiden, kan medføre redusert fokus på etiske og faglige hensyn, og økt fokus på lønnsom drift. Teknologisk utvikling har også konsekvenser for tannhelsetjenesten, hvor tilbudet av dyrere og mer avansert utstyr øker. Dette kan påvirke behandlingsmuligheter, arbeidsmetoder, forventninger blant pasientene, kompetansekrav og økte kostnader.

12.4 Behov for likeverdig tilgang til tannhelsetjenester for alle

Noen grupper i befolkningen har et udekket behov for tannhelsetjenester. NTF støtter at det bør være likeverdig tilgang til tannhelsetjenester for alle.

12.4.1 Behov for kontinuerlig arbeid med forebygging

NTF støtter at det er behov for et kontinuerlig helsefremmende og forebyggende arbeid siden flere av de vanligste tann- og munnhelseproblemer kan forebygges. Grunnlaget for god folkehelse legges ikke i helsetjenesten. Ikke-smittsomme sykdommer må forebygges ved redusert bruk av alkohol og tobakk, gode kostvaner og økt fysisk aktivitet. Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene kan utviklingen og forløpet av flere sykdommer påvirkes samtidig. Gjennom folkehelsearbeidet må samfunnet påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse, og på den måten legge til rette for at befolkningen skal kunne ta kloke og sunne valg. Det er sosial ulikhet og en sosial gradient i helse, og dette kan motvirkes. Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer på nasjonalt nivå på en bedre måte enn i dag.

Tannhelsetjenesten må ta en mer sentral plass i folkehelsearbeidet, som en naturlig del av helsetjenesten, og gjennom økt samhandling med den øvrige helsetjenesten. Hele tannhelsetjenesten må bidra i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og dette må være en viktig del av tannhelsetilbudet til befolkningen. Helsekompetansen i befolkningen er ikke god nok og må styrkes.

Måltrettet helsefremmende og forebyggende arbeid bidrar til god munnhelse. Munnhelse er like viktig i et livsløpsperspektiv som øvrig helse. God munnhelse innebærer at man ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser og sykdom i munnhulen, at man har tilfredsstillende tyggefunksjon og at man kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene og munnen. En frisk munn er viktig for god helhetlig helse (fysisk og psykisk), for god motstandskraft mot sykdom, for god ernæring og for god samhandling med andre mennesker.

Tannhelsetjenesten vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid, og nedlegger en vesentlig innsats med å lære opp befolkningen til egenomsorg for tenner og munnhule. Tannhelsetjenesten driver forebyggende arbeid i stor utrekning, i både privat og offentlig tannhelsetjeneste, ved å forebygge og stanse infeksjoner i munnhulen som mulig kan innebære risiko for pasientens helse. Belastningen på helsevesenet reduseres på denne måte betraktelig. Forebygging av alvorlige infeksjoner med odontogent opphav er dessuten viktig for å få ned bruk av antibiotika.

Sunt kosthold fremmer helse og forebygger kostholdrelaterte sykdommer. Reduksjon i sukkerinntak er viktig gjennom hele livsløpet, men særlig for barn og unge. Høyt sukkerforbruk er en viktig risikofaktor for ikke-smittsomme sykdommer, inkludert karies, som er den vanligste sykdommen relatert til munnhule og tenner. Karies er den vanligste av alle sykdommer globalt. Til tross for at karies er betydelig redusert i Norge de siste 20-30 årene er det fremdeles mye karies hos visse grupper av befolkningen.

Syreholdig drikke har lav pH og kan gi alvorlige syreskader på tennene. Det er vanskelig for forbrukerne å orientere seg om hvilke drikker som er skadelige for tennene. Inntak av sure drikker med og uten sukker, og da spesielt drikker som ofte inneholder både sukker og koffein, øker hos barn og ungdom.

God munnhelse, og med det muligheten til et godt og næringsrikt kosthold, er spesielt viktig for den økende andelen eldre i befolkningen, for dem som lever med kronisk sykdom eller overlever

alvorlig sykdom. Økt medikamentbruk og andre type medisinske behandlinger, som for eksempel kreftbehandling fører ofte til munntørrehet. Munntørrehet er en stor belastning for pasientene og fører ofte til redusert livskvalitet. Undersøkelser viser at dette rammer flere kvinner enn menn, og det må derfor også ses i et kvinnehelseperspektiv.

Røyking er den største risikofaktoren for tapte leveår i befolkningen. Det må legges bedre til rette både for snus- og røykeslutt. Særlig viktig er det forebyggende arbeidet for å hindre at flere begynner med tobakk. Tannhelsetjenesten må inkluderes i dette arbeidet på en bedre måte enn i dag. Bruk av tobakk (inkludert snus og e-sigaretter) har stor påvirkning på munnhelsen ved at det øker sjansen for sykdom og skade i tennenes festeapparat, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. Likevel er ikke tannlegene involvert i det tobakksforebyggende arbeidet i dagens helsetjeneste på en god nok måte.

Det er en utfordring i dag at avgiftspolitikken ikke er helsebegrunnet, og at det fortsatt er utstrakt markedsføring av usunn mat og drikke til barn og ungdom. Skadelige matvarer er ikke godt nok merket og det er fortsatt lov med smakstilsetninger i tobakk som snus.

Det er klare sosiale forskjeller i forekomst av tann- og munnsykdommer, og ulikhetene følger tydelige sosiale mønstre. Arbeidsledige, uføre og de med lav inntekt og utdanning har dårligere munnhelse enn resten av befolkningen. Dårlig munnhelse er stigmatiserende og kan bidra til utenforskap og vanskeliggjøre tilgang til arbeidslivet og andre sosial situasjoner.

NTF vil understreke at tannhelsepersonell læres opp til å avdekke misbruk, vold og overgrep, og er i en særstilling til å avdekke dette ettersom barn og ungdom innkalles jevnlig til undersøkelser slik at de følges over år. Dette arbeidet må videreføres og utvikles i samarbeid med resten av helsetjenesten.

12.4.2 Behov for et helhetlig ansvar for barn og unge

NTF støtter at det er en utfordring at barn og unge i dag ikke har tilgang til kostnadsfrie nødvendige tannhelsetjenester. I dag er det ikke full offentlig finansiering av nødvendig kjeveortopedisk behandling til barn og unge. Barn og unge får i dag stønad til nødvendig kjeveortopedisk behandling gjennom folketrygdens stønadsordning. Ordningen er ikke fullfinansiert og mange med behov for behandling får bare dekket en prosentvis andel av behandlingen.

Folketrygdens stønadsordning for tannhelsetjenester dekker bare en andel av utgifter til tannbehandling for de som får stønad fra ordningen. Stønaden har aldri dekket de faktiske og totale utgiftene til behandling, og stønadstakstene har heller ikke de siste årene fulgt prisstigning, noe som gjør at egenandelen pasientene betaler har økt.

Det er behov for økt offentlig finansiering for å sikre barn og unge rett, og tilgang til, også nødvendig kjeveortopedisk behandling på lik linje med annen nødvendig tannbehandling.

12.4.3 Behov for å ivareta utsatte og sårbare grupper

NTF mener at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten. Odontologisk behov må være avgjørende for prioritering av nødvendig og forsvarlig tannbehandling på individnivå, slik medisinske behov er avgjørende for prioritering av helsetjenester. Slik er det ikke i dag. Økt offentlig finansiering er avgjørende for at hele befolkningen i fremtiden, skal få rett på, og tilgang til, nødvendige tannhelsetjenester. Systemet må på en bedre måte enn i dag sikre at økonomi ikke utgjør en barriere for å motta tannhelsehjelp.

Det må utredes nærmere hva som er nødvendig tannbehandling. Her må fagmiljøene ha en avgjørende rolle i arbeidet.

Man må se på oppgavefordeling i tannhelsetjenesten for å sikre at kompetansen og ressursene i tjenesten utnyttes på en god måte. Nødvendig offentlig finansiert tannbehandling må også kunne utføres av tannleger i privat tannhelsetjeneste, og det kan hende at mange av de pasientgruppene som behandles av den offentlige tannhelsetjenesten i dag, i fremtiden kan behandles i privat tannhelsetjeneste. I dag utnyttes ikke de samlede ressursene i tannhelsetjenesten godt nok. Det må vurderes hvilke pasienter som bør behandles av den offentlige tannhelsetjenesten i fremtidens tannhelsetjeneste, hvilke tjenester det offentlige bør tilby selv, og hvilke tjenester som kan utføres ute i privat tannhelsetjeneste. Økt samhandling mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten må sikre at de mest sårbare pasientene ivaretas på en bedre måte enn i dag.

Folketrygdens stønadsordning gir i dag enkelte pasienter rettigheter til stønad til tannbehandling etter helt spesifikke kriterier, men er komplisert og regelstyrt. Den gir kun stønad til enkelte pasientgrupper, mens andre grupper, med store behov, er utelatt fra ordningen. Stønaden gis ofte på bakgrunn av medisinske diagnoser og det er ikke behovet for tannbehandling som styrer hvem som får stønad. Ordningen er vanskelig å forstå for pasientene og krevende å bruke for behandlerne. Finansieringen er dessuten mangelfull, noe som fører til at mange pasienter får høy egenbetaling selv om de mottar stønad. Ordningen har reelt sett aldri dekket de faktiske og totale kostnadene til behandling. Ordningen medfører behov for etterkontroll, men ut over det lite administrasjon. Det er også en særlig utfordring at folketrygdens stønadsordning ikke gir stønad til helsefremmende eller forebyggende behandling. I fremtidens tannhelsetjeneste er det avgjørende å sikre ordninger som ivaretar helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre en bærekraftig tjeneste.

Det er pasientene som har rettigheter i folketrygdens stønadsordning. NTF vil imidlertid påpeke at ordningen i dag er lagt opp slik at tannlegene "legger ut for pasientbetaling", før de så får refusjon fra Helfo. Etter kontroll kan Helfo kreve penger tilbake, også hvis det bare er begått formelle feil og pasienten har hatt krav på stønad. Dette medfører at tannlegene tar stor økonomisk risiko i dagens ordning.

Det er behov for en total gjennomgang og store endringer for at denne ordningen skal kunne brukes i et system hvor hele befolkningen skal ha rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

12.4.4 Behov for å ivareta eldre med kognitiv svikt og skrøpelighet

NTF støtter utvalgets vurderinger om at flere eldre beholder sine tenner lenger, og at dette er positivt. Samtidig vil en aldrende befolkning føre til flere aldersrelaterte sykdommer som skrøpelighet, kognitiv svikt og demens. Dette vil påvirke tannhelsetjenesten, da flere vil trenge hjelp til daglig tannhygiene. Tenner med restaureringsarbeid hos pasienter med redusert evne til egenomsorg vil kreve regelmessig kontroll og behandling. Det vil også være behov for bedre samarbeid med helsetjenesten, pårørende og omsorgstjenesten.

Dagens system for tannhelsetjenester for eldre på institusjon og med hjemmesykepleie fungerer ikke godt nok. Hjemmeboende eldre har lavest andel tilsyn fra fylkeskommunale tannhelsetjenester. Samarbeid med kommunene om hjemmeboende og institusjonspasienter med rett til tannhelsetjenester er en utfordring.

Pasienter mister stønad til tannbehandling fra folketrygden når de får rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller andre ordninger, som for eksempel eldre i gruppe c (eldre,

langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie). Det er en utfordring at pasienter som får rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten i dag må bytte tannlege fra sin faste tannlege i privat tannhelsetjeneste for ikke å miste sine rettigheter. Mange velger derfor å ikke benytte seg av tilbudet. De mister da likevel sine rettigheter i folketrygdens stønadsordning. Disse pasienten burde kunne fortsette hos sin egen tannlege i privat tannhelsetjeneste, selv om de får rett til offentlig finansierte tannhelsetjenester.

NTF vil understreke at det er avgjørende med helsefremmende og forebyggende arbeid, spesielt for eldre som rammes av annen somatisk eller psykisk sykdom. Denne gruppen har behov for tett oppfølging. Samhandlingen mellom tannhelsetjenesten og helsetjenesten er ikke god nok i dag, det fører til at oral sykdom ikke forebygges godt nok, og at gruppen får et stort behov for tannbehandling. Annet helse- og omsorgspersonell får for lite opplæring i viktigheten av god munnhygiene og god tann- og munnhelse.

12.4.5 Behov for å se sammenhengen mellom oral sykdom/skade og øvrig helse

Oral helse påvirker somatisk helse på flere områder. Økt kunnskap om sammenhengen mellom oral helse og somatisk/psykisk helse er viktig for videreutviklingen av tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenesten ser store deler av befolkningen regelmessig og har derfor også en viktig rolle når det gjelder psykisk helse. Dette gjelder spesielt hos barn og unge, og særlig knyttet til områder som omsorgssvikt, vold og kroppspress, men også i å fange opp psykisk sykdom, som for eksempel spiseforstyrrelser. Det er en tendens i samfunnet til økt kroppspress, særlig blant unge. Det er en sammenheng mellom kropps- eller utseendepress og det økende markedet for kosmetiske behandlinger.

Den psykiske helsen kan i vesentlig grad påvirkes av den orale tilstanden. Dårlig oral helse har en betydelig innvirkning på både selvtillit og selvfølelse, og tanntap og dårlig oral hygiene kan utgjøre en stor psykisk belastning. Rusmiddelbruk fører til redusert oral helse. Rusmiddelbrukere kan ha store problemer med å ta vare på seg selv og sin egen orale helse, og de har et større udekket behov for tannbehandling enn resten av befolkningen. De går mindre regelmessig til tannbehandling og mange sliter med tannbehandlingsangst.

NTF støtter utvalget i at det er avgjørende å ha med seg dette i det videre arbeidet med å utvikle tannhelsetjenesten som en del av helsetjenesten. Det er for lite samhandling mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten, og spesielt pasienter i spesialisthelsetjenesten har ikke god nok tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

12.4.6 Behov for å redusere risiko for store utgifter

I dag betaler voksne selv for tannbehandling, noe som skiller tannhelsetjenester fra andre helse- og omsorgstjenester. Som del av en universell rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester må myndighetene sørge for tilstrekkelig finansiering av tannhelsetjenester. Befolkningen er i dag ikke sikret tilgang til nødvendige tannhelsetjenester når de har behov for det. I dag er den offentlige finansieringen for dårlig, noe som medfører at hele befolkningen i dag ikke har rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Økonomi utgjør i dag en barriere for å motta tannhelsehjelp, og nødvendige tannhelsetjenester finansieres ikke på lik linje med andre nødvendige helsetjenester. Økonomi er den vanligste årsaken til udekket behov for tannhelsetjenester. I Norge er det en høyere andel av befolkningen som oppgir å ha et udekket behov for tannhelsetjenester enn gjennomsnittet i EU. Økonomi oppgis som den vanligste

årsaken til at voksne har et udekket behov for tannhelsetjenester, og bruken av tannhelsetjenester henger sammen med inntektsnivå. Personer i husholdninger med lavere inntekt går i mindre grad til tannlege enn de med høy inntekt.

Den private delen av tannhelsetjenesten mottar i dag ingen offentlig finansiering, og derfor er det også fri prissetting på tannhelsetjenester. NTF vil presisere at vi finner det naturlig at det er behov for å utrede og innføre prisreguleringer dersom tjenestene er fullt ut eller i hovedsak er offentlig finansiert.

Pasientene som i dag får stønad til nødvendig tannbehandling gjennom folketrygdens stønadsordning, får i dag betydelig egenbetaling. Ordningen er ikke fullfinansiert og mange med behov for behandling får bare dekket en avgrenset del av behandlingen. Ordningen er komplisert, og det er krevende for pasientene å forstå hvilke rettigheter de har. Mange tannleger opplever også at regelverket er vanskelig og uklart, og mange er engstelige for å bruke regelverket feil. NTF er på bakgrunn av dette bekymret for at mange pasienter derfor ikke får den stønaden de har krav på.

Utvalget skriver at de fleste har årlige tannhelseutgifter under 2 000 kroner, men 6-7 % har utgifter over 10 000 kroner. Eldre har generelt høyere utgifter enn yngre. Det er viktig å understreke at det at flertallet har lave utgifter til tannlege ikke er ensbetydende med at behovet for tannhelsetjenester er lite. Undersøkelsene sier bare noe om tannhelseutgiftene til de som faktisk går til tannlegen, ikke noe om de som ikke oppsøker tannlege fordi de ikke har råd til å få utført tannbehandling. Disse undersøkelsene tar heller ikke høyde for at de spurte kan ha et større behov for tannbehandling enn det de har fått utført, men at de av ulike årsaker, som for eksempel økonomi, har avstått fra nødvendig behandling eller valgt rimeligere behandling enn det anbefalte.

Dette kan også være årsaken til at undersøkelser viser at lavtlønnede tar ut mindre refusjon fra folketrygdens stønadsordning enn andre. Selv om de kan ha rett til stønad for enkelte deler av behandlingen kan egenbetalingen likevel bli så høy at de må avstå fra behandlingen. Det kan også hende at de blir tvunget til å velge en rimeligere og dårligere behandling enn den behandlingen som egentlig er nødvendig.

12.4.7 Behov for å styrke pasientenes kunnskap om prisnivået

NTF stiller seg bak at det i dagens situasjon er viktig å styrke befolkningens kunnskap om prisnivået på tannhelsetjenester, og at tjenesten følger regelverket for prisopplysning. I dag kan det være krevende for pasienten å tilegne seg god prisinformasjon. Vi reagerer derimot på at utvalget særlig bes om å vurdere hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres. Tannhelsetjenester er spesialiserte tjenester som krever avansert utstyr og kompliserte arbeidsprosedyrer. Tannhelsetjenesten leverer i dag tannhelsetjenester av høy kvalitet til befolkningen på en kostnadseffektiv måte. Organiseringen av tjenesten med små og mellomstore tannlegeeide virksomheter gir lite administrasjonskostnader. Men for å levere tannhelsetjenester kreves store investeringer som gjenspeiles i kostnadsnivået i tjenesten.

En rapport utarbeidet av Oslo Economics for NTF i 2024; *Kartlegging av den private tannhelsetjenesten*, viser at den private tannhelsetjenesten står for en stor del av det samlede tjenestetilbudet. Tjenesten bidrar til verdiskaping ved å dekke befolkningens behov for tannhelsetjenester, skape attraktive arbeidsplasser og ved sitt skattebidrag til samfunnet.¹⁰

¹⁰<https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.7add97c51900c61ec176d068/1736347563937/Oslo%20Economics%20-%20Kartlegging%20av%20den%20private%20tannhelsetjenesten.pdf>

Markedet for private tannlegetjenester er i endring. Dette påvirker ikke bare pasientene, men har også betydning for arbeidsforhold og eierskap.

Oslo Economics skriver videre at den private tannhelsetjenesten bidrar med betydelig verdiskaping, og at denne kan måles langs flere dimensjoner. Omsetningen viser inntektene som skapes, og reflekterer etterspørselen av tannhelsetjenester i samfunnet. Investeringene sier noe om graden av langsiktig forpliktelse og vektlegging av pasientopplevelser. Sysselsettingen belyser hvordan tjenesten skaper arbeidsplasser, og skattebidraget viser hvor store verdier som går tilbake til fellesskapet. De finner at den samlede omsetningen i privat tannhelsetjeneste utgjør om lag 13,6 milliarder kroner i 2022. Skattebidraget er estimert til cirka 2,5 milliarder kroner i året. Den private tannhelsetjenesten sysselsetter omtrent 9 000 personer. Totale initiale investeringer i tilrettelegging av behandlingsrom med utstyr i praksisene finner vi er på litt over 10 milliarder kroner (2022-kroner).

Det er et problem at befolkningen selv i dag stort sett må betale for sine egne tannhelsetjenester, og at den offentlige finansieringen er for lav. Det gjør at en del ikke har råd til å motta nødvendige tannhelsetjenester.

Dagens lowverk er komplisert og vanskelig for pasientene å forstå. En harmonisering av tannhelsetjenesten vil antagelig gjøre det enklere for pasientene.

Tannhelsetjenester er en helsetjeneste, og det er uansett krevende å gi god nok prisopplysning til befolkningen. For å kunne gi en detaljert pris på en tannbehandling må tannlegen først undersøke pasienten. Først da kan pasientene få et riktig kostnadsoverslag. I en universell ordning vil dessuten prisopplysning slik vi kjenner den i dag være overflødig.

12.5 Behov for å sikre tannhelsetjenester av god kvalitet

NTF støtter at tannhelsetjenestene skal være kunnskapsbaserte. Tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten og må ha tilgang de samme tjenestene og virkemidlene som resten av helsetjenesten. Det er en utfordring at det ikke er slik i dag.

12.5.1 Behov for å styrke kvaliteten på tjenestene

NTF vil understreke at kvaliteten på tannhelsetjenester som leveres i Norge er god. Tannhelsetjenesten er en spesialisert helsetjeneste som leverer avansert tannbehandling. Omdømmeundersøkelser viser at pasientene er fornøyde med tannhelsetjenesten, og store deler av befolkningen går til tannlegen regelmessig og har relativt god tannhelse.

Men, vi mangler kunnskap om hele tannhelsetjenesten, både den offentlige og private. NTF støtter at det er behov for økt kunnskap og innsikt i tannhelsetjenesten. Utvalget peker på at det er viktig å inkludere data fra tannhelsetjenesten i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). NTF støtter dette, men vil påpeke at KPR ikke er et kvalitetsregister og at det antagelig vil være behov for utvikling av kvalitetsregistre selv om det blir tilrettelagt for data fra tannhelsetjenesten til KPR.

Utvalget peker på de regionale odontologiske kompetansesentrenes (ROK) rolle i tannhelsetjenesten. NTF vil understreke at de odontologiske lærestedene også har en svært viktig rolle i tannhelsetjenesten, ikke bare som utdanningsinstitusjon, men også for forskning og kompetanseheving i tjenesten. Det er den odontologiske utdanningen, både grunn- og spesialistutdanningen, som legger grunnlaget for kvalitet i tjenesten, og NTF er bekymret for tilbakemeldinger fra dagens odontologiske læresteder om utilstrekkelig finansiering. De

odontologiske lærestedene er viktige kompetansemiljøer som må sikres tilstrekkelige ressurser og tilgang på tannhelsepersonell. Etableringen av ROKene har ført til en splittelse av allerede små sårbare fagmiljøer. Ulik finansiering og organisering av de odontologiske lærestedene og ROKene, med ulike lønns- og arbeidsforhold, har blitt et hinder for godt samarbeid. Splittelsen har bidratt til konkurranse om både personell og ressurser, som ikke har gagnet tannhelsetjenesten. Se mer under punkt 12.9.

Prioriteringskriteriene gjelder for tannhelsetjenesten, og NTF støtter at det er behov for å utvikle retningslinjer og veiledere for tannhelsetjenesten. Det er også helt avgjørende å utrede hva som er nødvendig tannbehandling som bør være offentlig finansiert. Her må hele det odontologiske fagmiljøet involveres i arbeidet.

12.5.2 Behov for å styrke tannhelsetjenestens ansvar for forskning og praksis i utdanningene

Det er stort behov for klinisk forskning som er viktig for tannhelsetjenesten. Igjen vil NTF påpeke at de odontologiske lærestedenes også har en viktig rolle i den kliniske forskning, i tillegg til ROKene.

Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for forskning, noe som er viktig for å holde seg oppdatert på medisinsk utvikling. Kommunene har et mindre ansvar for forskning, men skal medvirke til å tilrettelegge for forskning og opplæring av helsepersonell. Tannhelsetjenesten har ikke det samme ansvaret for å bidra til forskning i tannhelsetjenesten.

NTF støtter at det i fremtidens tannhelsetjeneste bør legges bedre til rette for forskning i hele tannhelsetjenesten, også klinisk forskning. Det samme gjelder for praksisstudier under utdanning. Her bør hele tannhelsetjenesten benyttes for å sikre relevant erfaring fra praksis. Det er en utfordring at tjenesten i dag ikke er forpliktet til å bidra i forskning eller i utdanningen av tannhelsepersonell.

Odontologiutdanningen er kostnadskreven utdanning, og de odontologiske lærestedene er i dag underfinansiert. En stor del av utdanningen består av praktisk trening, og det er svært viktig at finansieringen er tilstrekkelig slik at man sikrer at praksis i utdanningen opprettholdes, samtidig som studentene får tilstrekkelig klinisk undervisning på lærestedene. I dag er de odontologiske lærestedene helt avhengig av pasientinntekter, noe som fører til at prisene må settes relativt høyt. Dette medfører redusert tilgang til pasienter og dermed redusert praktisk trening for studentene.

De odontologiske lærestedene har dessuten hovedansvaret for utdanning av spesialister, og dette henger tett sammen med grunnutdanningen.

12.5.3 Behov for å vurdere videre innretningen av tjenesteinnovasjon

NTF mener at det må legges enda bedre til rette for utviklings- og innovasjonsprosjekter i tannhelsetjenesten, men også prosjekter som integrerer tannhelsetjenesten med resten av helsetjenestene. Det er for få slike prosjekter i dag. Det er viktig å involvere hele tjenesten, både privat og offentlig sektor, samt de odontologiske lærestedene, på en bedre måte enn i dag.

12.5.4 Behov for økt digitalisering

NTF støtter utvalgets beskrivelse av at tannhelsetjenesten ligger bak de øvrige helsetjenestene i bruk av nasjonale e-helseløsninger i dag. Tannhelsetjenesten inkluderes ikke i arbeidet med nye e-helseløsninger og digitalisering i helsetjenesten på en tilstrekkelig måte i dag. De aller fleste tannleger har vært tilknyttet Norsk Helsenett i en årrekke, og har hatt store utgifter forbundet med dette, men har fortsatt ikke tilgang til viktige tjenester, som e-resept og kjernejournal. Dette svekker pasientsikkerheten og det er ikke bærekraftig. Myndighetene må ta ansvar for dette og sikre at tannhelsetjenesten får tilgang til alle relevante tjenester som utvikles på en bedre måte fremover.

12.6 Behov for å vurdere klageordninger og økt tilsyn

NTF støtter utvalget i at det er krevende for befolkningen å orientere seg om sine rettigheter i dagens tannhelsetjeneste. Det er også vanskelig å orientere seg i dagens klageordninger. NTF mener likevel at mange av ordningene som eksisterer i dag fungerer godt, og at det ikke er behov for egne særordninger for tannhelsetjenester.

NTF vil likevel understreke at pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten kan få bistand fra pasient- og brukerombudet, men at dette ikke gjelder for pasienter i privat tannhelsetjeneste. Det er svært uheldig.

Hvis tannhelsetjenesten skal harmoniseres med resten av helsetjenesten bør den ha de samme klageordningene som resten av helsetjenesten. Det vil gjøre det enkelt for pasientene. I en universell tannhelsetjeneste vil det ikke være behov for en klagenemd for pris.

Når det gjelder tilsyn deler NTF utvalgets bekymring for at det ikke utføres nok tilsyn med tjenesten. Helsetilsynet har denne oppgaven i dag, men det gjennomføres svært få tilsyn i tannhelsetjenesten. Helsetilsynet må gis ressurser til å ivareta sin rolle som tilsynsmyndighet på en bedre måte enn i dag.

12.7 Behov for samhandling og samordning med helse-, omsorgs- og sosialtjenester

NTF støtter utvalget på at det er behov for mer samhandling, og samordning mot øvrige helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

12.7.1 Behov for bedre samhandling med helse-, omsorgs- og sosialtjenester

NTF støtter at samhandlingen med øvrig tjeneste ikke er god nok. Samhandlingen er i dag for dårlig og det finnes ikke gode nok digitale verktøy. Det er viktig at det fremover tilrettelegges for et mye bedre samarbeid mellom tannhelsetjenesten og resten av helse-, omsorg- og sosialtjenesten enn det gjøres i dag.

12.7.2 Behov for å integrere tannhelsetjenester i øvrig helse- og omsorgstjeneste i større grad

NTF mener at det er viktig at tannhelsetjenesten harmoniseres bedre med resten av helsetjenesten. Det er viktig å se på hvordan tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide og samhandle, og hvordan oral helse best kan følges opp og ivaretas hos de pasientene som har behov for behandling og oppfølging i begge tjenester, da det ikke gjøres i stor nok grad i dag.

Det er også en utfordring at det er geografisk variasjon og ulik tilgang til akutt tannhelsehjelp i Norge, som baserer seg på både offentlig og privat tannlegevakt, samt kommunal eller interkommunal legevakt. Det er viktig å sikre ordninger som gir et likere tilbud til nødvendig akutt tannhelsehjelp for hele befolkningen.

12.7.3 Behov for å samordne helseberedskapen

Erfaringen fra koronapandemien viste at myndighetene i stor grad manglet oversikt over privat tannhelsetjeneste og at bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven som er ment som samordnings- og styringsbestemmelser ikke fungerte. Tannhelsetjenesten er en viktig helsetjeneste og NTF mener at tannhelsetjenesten må integreres i beredskapsplaner på alle nivåer på en bedre måte enn i dag. Det er en utfordring at myndighetene ikke har god oversikt over tannleger i Norge, og at de ikke har kommunikasjonskanaler til tjenesten som fungerer.

Iht. tannhelsetjenesteloven skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Videre har fylkeskommunen ansvaret for samordning av den offentlige og den private tannhelsetjenesten, og er forpliktet til å motta og registrere meldinger om helsepersonell i fylkeskommunen og i tannhelsetjeneste. Som følge av en utilsiktet endring i helsepersonelloven § 18 om meldeplikt kan fylkeskommunen ifølge Helsedirektoratet imidlertid ikke pålegge private tannhelsepersonell meldeplikt da meldinger nå i stedet skal sendes til kommunen. Dette til tross for at det ikke er kommunen som har ansvaret for tannhelsetjenesten i dag.

Den offentlige tannhelsetjenesten har i dag derfor ingen oversikt over tannhelsepersonell i fylket, og de kan på den måten ikke ivareta sine samordningsplikter etter tannhelsetjenesteloven.

12.7.4 Behov for å sikre rett dimensjonering og effektiv bruk av personell

NTF støtter utvalget på at det bør utredes hvor mye tannhelsepersonell Norge har behov for fremover for å sikre en bærekraftig tannhelsetjeneste. Det er en utfordring at Norge i dag ikke utdanner nok egne tannleger. I dag kommer det svært mange tannleger fra utlandet til Norge og mange norske ungdommer reiser ut for å studere odontologi.

Helsedirektoratet oppgir at det de siste 10 årene årlig er innvilget rundt 300 autorisasjoner til tannleger, og at over halvparten av de som har fått autorisasjon i denne perioden er utdannet i utlandet¹¹. En stor andel av disse er norske studenter som tar utdanningen utenfor Norge. Det viser med tydelighet at Norge i dag ikke utdanner nok tannleger og at vi er avhengige av utdanningskapasitet i andre land. Dette er ikke bare etisk betenkelig, slik Helsepersonell-

¹¹ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-autorisert-helsepersonell>

kommisjonen påpeker, det er også problematisk i et beredskapsperspektiv.¹² NTF vet at de som studerer odontologi i utlandet ikke får god nok kjennskap til den norske helsetjenesten og norsk lowverk. De får dessuten varierende klinisk trening. I tillegg vil kommunikasjon med pasientene være utfordrende for de norske studentene i utlandet, da de ikke snakker samme språk som pasientene de behandler under studiet. NTF mener at dette er en uheldig utvikling.

NTF vil påpeke at økt offentlig finansiering av tannhelsetjenester, demografiske endringer og en harmonisering av tannhelsetjenesten med helsetjenesten vil medføre et stort behov for tannlegekompetanse og redusere en eventuell overkapasitet. Denne situasjonen er også beskrevet av Helsepersonellkommisjonen.¹³

Utredningen viser at antall tannbehandlere per innbygger i Norge økte med 4,6 % fra 2015 til 2022, med høyere vekst i det private markedet (5,4 %) enn i det offentlige (2,8 %). I 2022 var det 11,2 behandlerårsverk per 10 000 innbyggere, noe som tilsvarer omtrent 890 innbyggere per behandler. Norge har høyest tannlegedekning i Norden og er det eneste landet som har økt dekningen etter år 2000. Det er viktig å påpeke at de andre nordiske landene (bortsett fra Island) har en betydelig større andel tannpleiere, og en annen organisering av tjenesten. Norge skiller seg derfor ikke mye fra de andre landene i Norden hvis man ser på samlet antall tannhelsepersonell.

12.8 Behov for å tydeliggjøre rammene for den private tannhelsetjenesten

NTF støtter utvalgets beskrivelse av at den private tannhelsetjenesten er i endring. Det skjer en konsolidering i tjenesten, hvor det i hovedsak er noen store investor-eide virksomheter som kjøper opp tannklinikker. Oppkjøpene drives ofte av internasjonale investorer med forventning om avkastning. NTF har hele tiden vært tydelige på at myndighetene må ha mer kunnskap om og bedre innsikt i privat tannhelsetjeneste, og er derfor positive til å hente inn data også fra privat tannhelsetjeneste. Det er viktig for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. NTF er bekymret for den nevnte utviklingen i den private tannhelsetjenesten, og mener at det er viktig at tjenesten er styrt av fagpersoner.

NTF er enige med utvalget i at konkurranseutfordringene i den private tannhelsetjenesten er komplekse, og det er derfor nødvendig med en helhetlig vurdering av konsekvensene for konkurransesituasjonen ved endringer i organisering og finansiering.

Oslo Economics skriver i en rapport utarbeidet for NTF i 2024; *Kartlegging av den private tannhelsetjenesten*, at det i tillegg til fremveksten av gruppepraksiser, også foregår konsolidering og kommersialisering i markedet. Praksiser blir større, og stadig flere tannleger velger å tilknyttes en kjede. De skriver videre at det er mange fordeler ved konsolidering; som muligheter til å utnytte seg av stordriftsfordeler, større fagmiljøer og bedre investeringsmuligheter. Dette kan bidra til lavere priser og bedre kvalitet på tjenestene til pasientene.¹⁴ Analyseselskapet Vista sin undersøkelse, som ble gjort på bestilling av Tannhelseutvalget, viser at det ikke er tilfelle. De store kjedene har i dag gjennomgående høyere priser enn de enkeltstående klinikkene.

¹² <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/>

¹³ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/>

¹⁴ <https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.7add97c51900c61ec176d068/1736347563937/Oslo%20Economics%20-%20Kartlegging%20av%20den%20private%20tannhelsetjenesten.pdf>

Samtidig peker Oslo Economics også på at det kan innebære mindre fleksibilitet og autonomi for tannlegene, samt økt risiko for at pasienter ikke følges opp av samme tannlege over tid. Endring i eierstrukturen til praksisene, som innebærer færre tannleger på eiersiden, kan dessuten medføre redusert vektlegging av etiske og faglige hensyn, og økt fokus på lønnsom drift.

NTF mener også at det er viktig at den faglige autonomien ikke settes i spill, uavhengig av hvilken virksomhet tannlegene arbeider i, og at det er faglige og etiske vurderinger som må styre tannhelsetjenesten. Som en del av helsetjenesten er det viktig at tannhelsetjenesten følger de samme kravene som i resten av helsetjenesten.

12.9 Behov for å vurdere forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten

NTF støtter utvalget i at forvaltningsnivå for den offentlige delen av tannhelsetjenesten bør drøftes for å sikre en harmonisering med resten av helsetjenesten. Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i fylkeskommunen, og tjenesten er organisert ulikt i de ulike fylkeskommunene, noe som fører til et svært ulikt tilbud til befolkningen.

DOT har i dagens fylkeskommunale modell store utfordringer med å levere de lovpålagte tjenestene. Penger til tannhelsetjenesten kommer fra rammebevilgninger til fylkeskommunene, og det er fylkespolitikkerne som igjen bestemmer hvor mye midler som skal fordeles til DOT. Det betyr at midler som bevilges av Stortinget til økte tannhelsetjenester ikke nødvendigvis kommer frem til DOT. Det er et utstrakt og kjent problem med dagens organisering.

Oslo Economics gjorde i 2024 en kartlegging av den offentlige tannhelsetjenesten for NTF. I rapporten *Kartlegging av organisering og finansiering av den offentlige tannhelsetjenesten* viser Oslo Economics at tannhelsetjenesten er ulikt organisert i de ulike fylkene.¹⁵

Rapporten viser at utvikling i totalt antall behandlede i den offentlige tannhelsetjenesten over tid viser en nedadgående trend. Den viser også at det er stor ulikhet mellom de ulike fylkene når det gjelder hvor stor andel av de prioriterte pasientene de behandlet. Andelen varierer mellom 40% i Oslo til 63 % i Rogaland.

Rapporten viser videre at resultatgraden (overskuddet) varierte mye mellom norske fylker i 2023, dessuten at resultatgraden varierer mye fra år til år.

Fylkeskommunene får frie inntekter fra staten. Disse er beregnet ut fra kostnadsnøkler for de ulike fylkeskommunale tjenestene. Det er likevel opp til fylket selv å velge nivået på tildelinger til ulike tjenester. Delkostnadsnøkkelen for tannhelse har utgjort 4%, men vil utgjøre 4,5 % av samlet kostnadsnøkkel for fylkeskommunene fra og med 2024 og fremover. DOTs andel av totale fylkeskommunale kostnader er målt i fylkets totale kostnader til tannhelse, relativt til fylkets totale brutto driftsutgifter. De fylkesvise variasjonene spenner ifølge rapporten fra 3,0 % av fylkeskommunale kostnader til 4,8 % av fylkeskommunale kostnader. I 2023 var gjennomsnittet for fylkeskommunale utgifter 10,6 milliarder kroner. Forskjellen fra 3,0 % til 4,8 % utgjør dermed omtrent 196 millioner kroner.

¹⁵<https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.512026e71942f6441345fa5e/1736347496095/Oslo%20Economics%20-%20Kartlegging%20av%20organisering%20og%20finansiering%20av%20DOT.pdf>

NTF mener at disse tallene viser at det er behov for å vurdere forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten, spesielt fordi disse ulikhetene viser at tilbudet til befolkningen varierer i de ulike fylkene.

Fylkestannhelsesjefene uttaler også i rapporten at den måten tilbudet til den offentlige tannhelsetjenesten i dag utvides på, gjennom endringer i statsbudsjettet som for eksempel for 21-28-åringene, er meget krevende. Utvidelsen av tjenestetilbudet oppleves uforutsigbar, både fordi endringene innføres med kort varsel samt fordi endringene ikke er tilstrekkelig forankret i tjenesten, og ikke i tråd med det de opplever som fornuftig forvaltning og utvidelse av tjenesten.

Tildelingen av midler kommer også til grupper som ikke har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, og det medfører at mange fylker velger å bruke midlene til andre formål. En utvidelse av DOTs tilbud krever dessuten av kapasiteten bygges ut. Dette kan innebære store investeringsprosjekter og byggeprosjekter som vil ta lang tid å ferdigstille. I tillegg er det krevende å engasjere nytt personell. Mange fylker opplever allerede utfordringer knyttet til rekruttering. Utvidelse av tjenesten gjør dette behovet og disse utfordringene stadig større. Også for fylkene som har mindre utfordringer knyttet til rekruttering, er det krevende å øke kapasiteten til personellet på kort sikt.

NTF er svært kritiske til de endringene som har blitt gjort for aldersgruppen 21-28 år og har gitt uttrykk for dette i tidligere høringsinnspill¹⁶. De midlene som er satt av til denne aldersgruppen er heller ikke tilstrekkelige hvis hele gruppen skal få et tilbud, og det kan igjen føre til at andre prioriterte grupper ikke får den behandlingen de har krav på. Det er også utfordrende for privat tannhelsetjeneste som mister et stort pasientgrunnlag.

Undersøkelser viser at en del av pasientgruppene som DOT har ansvar for i dag, men som ikke har lovfestede rettigheter, som pasienter i TOO-ordningen (tortur- overgrep og odontofobi), ikke har et godt nok tilbud.

NTF vil dessuten understreke at det er behov for i denne sammenhengen også se på de regionale odontologiske kompetansesentrene. Tannhelseutvalget peker på de positive erfaringene med kompetansesentrene i sin rapport, men evalueringen utført av PwC i 2023 peker også på en hel del som ikke fungerer.¹⁷

Da de regionale odontologiske kompetansesentrene ble opprettet var det helt andre utfordringer i tannhelsetjenesten enn det en har i dag. Sentrene utfører fortsatt viktige oppgaver og har vært, og er, spesielt viktige for DOT. De bidrar med spesialistbehandling av prioriterte grupper, forskning, kunnskapsutvikling og støtte, og sentrene bidrar også noe i spesialistundervisning, selv om PwC vurderer at kompetansesentrenes deltakelse i spesialistutdanningen ikke har ført til en større geografisk spredning av tannlegespesialister.

PwC sier videre at ROKene bør ha en større geografisk spredning og fysisk tilstedeværelse i regionene. Evalueringen viser også at sentrene ikke bidrar godt nok opp mot den private tannhelsetjenesten.

NTF er enige i denne beskrivelsen av kompetansesentrene. Vi mener, som tidligere nevnt, at etableringen av ROKene har ført til en splittelse av allerede små sårbare fagmiljøer og at man har fått en konkurranse om både personell og ressurser som ikke har gagnet tannhelsetjenesten. PwC sier også at kompetansesentrene til dels har lange ventetider og at

¹⁶<https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.704c98c7194ad0e3cb6453bd/1738230504225/H%C3%B8ringssvar%20fra%20Den%20norske%20tannlegeforening%20%20-%20Forslag%20om%20endringer%20i%20lov%20om%20tannhelsetjenesten.pdf>

¹⁷ <https://www.regjeringen.no/contentassets/0a052a47e83444aeb9c1eb37ea5edf31/evaluering-av-regionale-odontologiske-kompetansesentre.pdf>

flere av sentrene har kapasitetsutfordringer som følge av rekrutteringsproblemer og sårbarhet i bemanning. De stiller også spørsmål i sin evaluering om det er hensiktsmessig at alle sentrene skal bygge opp samme kompetanse innenfor alle fagområder.

Det er dessuten viktig å merke seg at hele 7 fylkeskommuner ikke er tilknyttet et kompetansesenter i dag. NTF mener at det viser at det er behov for å se på om også det er behov for å vurdere kompetansesentrenes funksjon og oppgaver og om midlene brukes på best mulig måte for pasientene og samfunnet. Slik det er i dag er det ingen nasjonal overbygning eller styring av hverken DOT eller ROKene, og ingen av kompetansesentrene har et overordnet ansvar for nasjonale oppgaver. Tvert imot bygges det opp mange små kompetansemiljøer som utfører mange av de samme oppgavene. NTF mener også at det er en utfordring at sentrene i svært liten grad bidrar til kompetanseheving og fagstøtte i hele tannhelsetjenesten.

12.10 Behov for bedre kunnskapsgrunnlag

NTF støtter at det finnes for lite kunnskap om hele tannhelsetjenesten, og at det er en utfordring for planlegging og styring fordi utvikling av tannhelsetjenesten må være kunnskapsbasert. Det er viktig å få bedre datagrunnlag, både fra den private og den offentlige tannhelsetjenesten, men også om tannbehandling som utføres andre steder, som hos de odontologiske lærestedene, i sykehusene og i forsvaret. Først da vil man få et helhetlig bilde av tannhelsetjenesten.

Den private tannhelsetjenesten mottar ikke noen form for offentlig finansiering og det er noe av bakgrunnen for at det ikke finnes data. Men man har heller ikke tilstrekkelig data fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Myndighetene må legge bedre til rette for innsamling av data på en enkel og god måte, som er i tråd med lovverket. Det er viktig at det legges til rette for at data kan brukes konstruktivt av tjenesten, blant annet til læring og kvalitetsheving på en bedre måte enn i dag. NTF vil igjen presisere at det offentlige bør bekoste innhenting av data og ikke tillegge den private tannhelsetjenesten denne byrden.

DEL V – NTFs INNSPILL TIL KAPITTEL 13 EN UNIVERSELL TANNHELSETJENESTE – UTVALGETS FORSLAG

Tannhelseutvalget kommer med 40 forslag som de mener vil bidra til økt harmonisering med øvrige helse- og omsorgstjenester. Et samlet utvalg har gitt sin tilslutning til 34 forslag, mens det er uenighet om de resterende forslagene. Et flertall av forslagene vil kreve ytterligere utredning, men utvalget mener likevel at man har tilstrekkelig grunnlag for tiltakene som foreslås.

1 Målet er en universell tannhelsetjeneste

Forslag 1. Alle skal ha rett til nødvendige tannhelsetjenester

NTF støtter dette forslaget.

Nærmere begrunnelse i DEL II punkt 1.

2 Likeverdig tilgang til tannhelsetjenester for alle

Forslag 2. Tydeliggjøre den offentlige tannhelsetjenestens særlige ansvar for forebygging rettet mot barn og unge, og for å bidra til å styrke deres helsekompetanse gjennom et helt liv

NTF støtter forslaget.

NTF vil likevel understreke at det er svært viktig at den offentlige delen av tannhelsetjenesten også har ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid for hele befolkningen. Tannhelsepersonell ivaretar denne delen av arbeidet i møte med pasientene, men myndighetene må legge til rette og ha det overordnede ansvaret.

Forslag 3. Styrke den offentlige tannhelsetjenestens ansvar for forebygging, oppsøkende og målrettede tilbud for dem som har et særskilt behov

NTF støtter dette forslaget.

NTF vil likevel påpeke at ansvaret bør gjelde for hele befolkningen.

NTF vil dessuten understreke at mange av dem som har et særskilt behov også kan behandles i privat tannhelsetjeneste. Det er ikke alle i disse gruppene som nødvendigvis må behandles i det offentlige. NTF mener at det bør legges til rette for at disse pasientgruppene også kan få dette tilbudet i privat tannhelsetjeneste der dette er hensiktsmessig, slik at man har et fleksibelt system der pasientens behov imøtekommes, og der finansieringen følger pasienten til de tilbudene som passer best for dem. Et system som også sikrer at pasientene kan henvises til mer spesialiserte tjenester når det er behov for det.

Dersom den offentlige tannhelsetjenesten skal få et utvidet ansvar for brukere med særskilte behov må gruppen defineres, og det vil være behov for å tilføre tjenesten tilstrekkelige ressurser, både i form av penger og kompetanse. Det må dessuten legges til rette for god samhandling med øvrige helse- og omsorgstjenester.

NTF mener at dette ansvaret i fremtiden best vil la seg løse i en regional tannhelseforetaksmodell.

Forslag 4. Integrere oral helse i nasjonale folkehelsesatsinger og -kampanjer for å gjøre befolkningen i stand til å ivareta egen oral helse gjennom ulike faser av livet

NTF støtter dette forslaget.

Det er viktig å øke helsekompetansen i befolkningen. Mange orale sykdommer kan forebygges, og i fremtidens tannhelsetjeneste blir det viktig å forsøke å forhindre og forebygge sykdom enda bedre enn det vi gjør i dag, ved å sette pasientene i stand til bedre å ivareta sin egen tann- og munnhelse.

NTF mener dessuten at myndighetene må ta et større ansvar for det helsefremmende og forebyggende arbeidet. God helse skapes ikke i helsetjenesten alene. Avgiftspolitikken må være

helsebegrunnet og sukkeravgiften må gjeninnføres. Dessuten støtter NTFs regjeringens forslag om at markedsføring av usunn mat og drikke mot de under 18 år må forbys, og mener også at salg av energidrikker til de under 18 år må forbys. Alle sure drikker som kan gi syreskader må merkes med advarsel. Norge må ha en visjon om en fremtid uten tobakk og tobakksurrogater, og det må innføres forbud mot smakstilsetninger i tobakk og tobakksurrogater. Det må dessuten innføres standardiserte pakninger for tobakk og tobakksurrogater.

Forslag 5. Utrede hva som er nødvendig tannregulering for barn og unge, og innføre en rett til gratis nødvendig tannregulering for denne gruppen

NTF støtter dette forslaget.

NTF mener at alle skal ha rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, og for barn og unge bør slike tjenester være kostnadsfrie. Vi har likevel en del kommentarer til forslaget.

Barn og unge har i dag rett til nødvendig tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten kostnadsfritt, men det er ikke full offentlig finansiering av nødvendig kjeveortopedisk behandling til denne gruppen. Barn og unge får i dag stønad til nødvendig kjeveortopedisk behandling gjennom folketrygdens stønadsordning. Ordningen er ikke fullfinansiert og mange med behov for behandling får kun dekket en prosentvis andel av behandlingen.

Folketrygdens stønadsordning for tannhelsetjenester dekker bare en andel av utgifter til tannbehandling for de som får stønad fra ordningen. Stønaden har aldri dekket de faktiske og totale utgiftene til behandling, ordningen gir kun stønad til deler av behandlingen. Stønadsstakstene har heller ikke de siste årene fulgt prisstigning, noe som gjør at egenandelen pasientene betaler har økt.

Det er derfor behov for økt offentlig finansiering for å sikre barn og unge rett, og tilgang til, også nødvendig kjeveortopedisk behandling.

NTF vil også understreke at størstedelen av den kjeveortopediske behandlingen i dag utføres i privat tannhelsetjeneste av næringsdrivende spesialister, som har foretatt store investeringer i sine virksomheter. Det har vist seg å være en god ordning på mange måter. Det er god spredning av private kjeveortopedier i hele landet, og det gir forutsigbarhet og stabilitet for pasientene. Kjeveortopedisk behandling kan strekke seg over år, og det er viktig med forutsigbare rammebetingelser og stabilitet. I Norge utføres all kjeveortopedisk behandling av spesialister, etter henvisning fra tannlege eller tannpleier, noe som sikrer god kvalitet på behandlingen, samt at det kun er de som har behov for behandling som får behandling.¹⁸

Tannhelseutvalget har sett til Danmark og Sverige. De skriver at det kun er 27 % av et årskull i Sverige som får kjeveortopedisk behandling, og 25 % i Danmark, mot 42-44 % i Norge. NTF vil understreke at dette ikke medfører riktighet, da tallene fra Danmark og Sverige kun viser hvor mange som blir behandlet hos spesialist med stønad fra det offentlige, ofte med lang behandlingsskø. I Sverige og Danmark mottar mange pasienter kjeveortopedisk behandling av offentlige allmenntannleger, og undersøkelser viser at kostnadene for slik behandling er høye og resultatene dårlige.¹⁹ I tillegg faller pasientene som velger å gå til private spesialister utenfor statistikken. Dermed gir disse tallene et forenklet og upresist bilde av virkeligheten, som ikke kan bli brukt som sammenligningsgrunnlag for hvor mange som mottar kjeveortopedisk behandling i de ulike landene. Snarere viser denne sammenligningen hva som kan skje dersom

¹⁸ <https://academic.oup.com/ejo/article-abstract/15/1/7/459975?redirectedFrom=fulltext&login=false>

¹⁹ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8971995/>

norske myndigheter innfører et underfinansiert tilbud, og bør ikke være et eksempel til etterfølgelse.

NTF vil understreke at selv om det offentlige skal finansiere nødvendig kjeveortopedisk behandling for barn og unge, anbefaler vi at behandlingen fortsatt også kan utføres i privat tannhelsetjeneste, som i dag. Det er avgjørende for å kunne gi et godt tilbud til befolkningen at man utnytter ressursene og kompetansen i den private delen av tannhelsetjenesten, også når det gjelder kjeveortopedisk behandling. Det må utredes hvordan det kan inngås avtaler med de private spesialistene slik at behandlingen fortsatt kan utføres ute i distriktene. Den offentlige finansieringen må økes betraktelig og pasientene må sikres fortsatt rett og tilgang til nødvendig kjeveortopedisk behandling, samtidig som rammebetingelsene for de private spesialistene sikrer at det fortsatt kan utføres behandling av høy kvalitet. Kostnadene for kjeveortopediske tjenester i Norge er, sammenlignet med lignende tjenester i naboland og andre land i Europa, relativt sett nøkterne.²⁰

NTF støtter at det må utredes hva som er nødvendig tannbehandling. Det inkluderer også hva som er nødvendig kjeveortopedisk behandling. Vi vil likevel påpeke at det gjennom flere år har vært gjennomført ulike prosjekter i regi av Helsedirektoratet hvor fagmiljøene sammen med myndighetene har sett på nettopp disse problemstillingene når det gjelder kjeveortopedi. Det gjør at på dette fagområdet har man allerede gjennomført flere slike vurderinger som man kan bruke videre. NTF er av den oppfatning at det i dag ikke gis stønad til behandling som ikke vurderes som nødvendig, og vi vil advare sterkt mot å innskrenke dagens grupper ytterligere.

Vi vet, som et eksempel, at barn og unge med intellektuelle funksjonsnedsettelse, som gruppe, ofte har de største bittavvikene og det største behandlingsbehovet, men likevel sjeldent blir henvist for kjeveortopedisk utredning og behandling²¹.

Nødvendig kjeveortopedi bør innebære både forebygging og korleksjon av bittanomalier eller funksjonsforstyrrelser som kan føre til helseproblemer, smerte, eller påvirke tyggefunksjon og estetikk. Det er spesielt viktig å styrke støtten til interseptiv kjeveortopedi, dvs. tidlig behandling, der man utnytter barnets vekst for å forenkle behandlingen og unngå større behandlingsbehov senere. Denne behandlingen har ofte ikke vært en del av folketrygdens stønadsordning, til tross for at den kan være avgjørende for å hindre videreutvikling av bittavvik.

Bittanomalier kan ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten, selvtilit og psykologisk velvære. En nylig studie viser at omtrent 9,7 % av barna blir mobbet på grunn av bittfeil. Dette tallet kan være høyere for barn som har andre utfordringer i tillegg.²²

NTF vil påpeke at vi ikke stiller oss bak vurderingene som er gjort av antatte kostnader for staten ved en eventuell innføring av kostnadsfri kjeveortopedisk behandling for barn og unge (utredningens vedlegg 2). I vedlegget skriver utvalget selv av de tar utgangspunkt i folketrygdens takster, men at de antagelig er for lave. NTF vil igjen minne om at folketrygdens takster i utgangspunktet er altfor lave, og at de aldri har dekket hele behandlingskostnaden. Stønadene var hele tiden ment å kun dekke deler av behandlingen. I tillegg har takstene de siste årene ikke fulgt prisstigningen. Flere prosedyrer dekkes heller ikke av takstene. Det medfører at pasientene i dag får en betydelig egenbetaling, selv ved nødvendig behandling. Dette gjelder også ved behandling hos kjeveortopedier som er ansatt i DOT eller på ROKene.

²⁰ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18854553/>

²¹ Arntsen, Torill, et al. "Orthodontic Treatment of Patients with Disabilities in Norway: A Survey Among Orthodontists." *Special Care in Dentistry*, 45.1, 2025

²² DiBiase, Andrew, et al. "Prevalence and nature of bullying in schoolchildren aged 10–14 years and its association with malocclusion: A cross-sectional study in the South East of the UK." *Journal of Orthodontics*, 2024

Det er helt nødvendig å utrede grundig hva kostnaden for den nødvendige kjeveortopediske behandlingen som skal utføres vil være, slik at den offentlige finansieringen blir tilstrekkelig, for både å sikre behandling av høy kvalitet, som i dag, og sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for tannhelsepersonellet.

Forslag 6. Utvide den offentlige tannhelsetjenestens ansvar for pasienter med særskilte behov

NTF støtter dette forslaget.

NTF viser til forslaget om universell tannhelsetjeneste hvor hele befolkningen skal ha rett til nødvendige tannhelsetjenester. Det utelukker ikke at den offentlige tannhelsetjenesten skal ha et utvidet ansvar for pasienter med særskilte behov.

NTF vil likevel igjen påpeke at man må utnytte ressursene i både privat og offentlig tannhelsetjeneste for å sikre hele befolkningen et nødvendig tannhelsetilbud. Det må legges til rette for et fleksibelt system hvor også en del av disse pasientene kan få behandling i privat tannhelsetjeneste, hvis det er hensiktsmessig.

NTF mener at dette ansvaret i fremtiden best vil la seg løse i en regional tannhelseforetaksmodell.

Forslag 7. Gi den offentlige tannhelsetjenesten ansvaret for Tverrfaglig psykolog og tannhelsetilbud til tortur-, overgrepsofre og personer med alvorlig angst for tannbehandling

NTF støtter dette forslaget.

NTF vil understreke at det i dagens modell er avgjørende med lovfesting av de oppgavene den offentlige tannhelsetjenesten skal ha ansvar for, ikke bare bevilge penger i statsbudsjettet. Ved en regional foretaksmodell vil den offentlige ha ansvar for at hele befolkningen skal ha tilgang til nødvendig tannbehandling, også denne pasientgruppen. Da blir denne anbefalingen overflødig.. Det er høy kompetanse i den private tannhelsetjenesten, også på behandling av denne pasientgruppen, som bør utnyttes på best mulig måte.

NTF mener at dette ansvaret i fremtiden best vil la seg løse i en regional tannhelseforetaksmodell.

Forslag 8. Innlemme orale helsetjenester i spesialisthelsetjenesten der de er en nødvendig og integrert del av behandlingen

NTF støtter dette forslaget under forutsetning at det er ansvaret for de orale helsetjenestene som skal innlemmes.

NTF er med i arbeidet som gjøres i Helsedirektoratet med orale helsetjenester i sykehus. Dette arbeidet viser at det er behov for å definere hvilke pasientgrupper som har behov for orale helsetjenester i spesialisthelsetjenesten og hvilken behandling de har behov for. Det er disse tjenestene spesialisthelsetjenesten bør ha ansvar for, slik at vi sikrer at pasientene får den helsehjelpen de har krav på. Noe av denne behandlingen må og bør utføres på sykehus. Det gjelder der tannbehandling er nødvendig for at pasientene skal få gjennomført behandling av annen alvorlig sykdom, der det er en økt medisinsk risiko ved å gjennomføre behandling utenfor sykehus eller der det er behov for tverrfaglig samarbeid med andre fagfolk i

spesialisthelsetjenesten. Orale helsetjenester i spesialisthelsetjenesten må sikres god finansiering, på lik linje med andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

NTF vil likevel understreke at selve behandlingen ikke nødvendigvis må utføres i spesialisthelsetjenesten for alle pasientene. Mye av den nødvendige tannhelsehjelpen kan utføres i klinikkene til de regionale tannhelseforetakene, eller i privat tannhelsetjeneste, hvis det er hensiktsmessig for pasientene. Dette må utredes nærmere og det må sikres fleksible løsninger med gode samarbeidsmuligheter- og avtaler.

NTF mener at denne samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og resten av helsetjenesten i fremtiden best vil la seg løse i en regional tannhelseforetaksmodell.

Forslag 9. Alle skal ha rett til akutt tannhelsehjelp

NTF støtter dette forslaget.

I en universell tannhelsetjeneste er dette en selvfølge. Det er en stor svakhet i dagens tannhelsetjeneste at alle ikke har rett til slik behandling. Det burde være helt selvsagt at hele befolkningen har rett og tilgang til akutt tannhelsehjelp. Akutt tannhelsehjelp innebærer hjelp ved traumer/skader, sterke smerter og alvorlige infeksjoner. Det kan ikke være avgjørende at man har råd til å betale for seg for å få hjelp i slike situasjoner. Når disse situasjonene ikke løses i tannhelsetjenesten, blir pasientene tvunget til å oppsøke annen helsetjeneste, som på den måten belastes med noe de ikke egentlig kan behandle eller har ansvar for.

Hvordan denne rettigheten best skal oppfylles må utredes nærmere. Det er naturlig å finne gode samarbeidsløsninger mellom både den offentlige og den private delen av tannhelsetjenesten, og tjenester som legevakt og akuttmottak.

Forslag 10. Utvide dagens frikort for helsetjenester til å omfatte egenandeler for nødvendige tannhelsetjenester. Opprette et eget frikort for tannhelsetjenester som en overgangsordning

NTF støtter forslaget om å utvide dagens frikort, men er skeptiske til et eget frikort for tannhelsetjenester, også som en overgangsordning.

Tannhelsetjenesten bør harmoniseres med resten av helsetjenesten. For pasientene vil det være en fordel at det gjøres ved å utvide og tilpasse de ordningene som i dag ellers finnes i helsetjenesten. Hvordan dette kan gjøres må utredes, men NTF mener at det er naturlig å se til helsetjenesten og de ordningene som allerede finnes der.

En slik ordning innebærer ikke at alle tannhelsetjenester skal være gratis. Egenandeler bør benyttes her som for øvrige helsetjenester. Det må utredes hvor store egenandelene skal være, og om enkelte grupper skal slippe å betale egenandel.

Dette forslaget betinger at det utredes hva som er nødvendig tannhelsehjelp. Forslaget innebærer at man går bort fra dagens ordning med stønadspunkter for tannbehandling i folketrygden. På lik linje med resten av helsetjenesten vil man kunne fastsette takster for definerte undersøkelser og behandlinger.

NTF mener at dagens frikort bør utvides. Det vil gi best harmonisering med resten av helsetjenesten og bidra til å ivareta sammenhengen mellom oral helse og annen helse. Pasienter med stort behov for både tannhelsetjenester og andre helsetjenester vil skjermes på en god måte i en slik ordning.

Utvalget har diskutert både høykostnadsbeskyttelse, universelt tannhelsetilskudd og tannhelseabonnement, samt målrettede skjermingsordninger som utvidelse av folketrygdens stønadsordning og egne tannhelsetilskudd. Utvalget mener at ingen av disse ordningene vil sikre alle rett til nødvendig tannhelsehjelp eller beskyttelse mot høye kostnader på en god nok måte. Det er dessuten krevende å finne målrettede løsninger som ivaretar alle grupper som har behov for det. Det er også det viktigste argumentet mot en utvidelse av stønadspunktene i folketrygdens stønadsordning. NTF støtter derfor forslaget om å utvide dagens frikort for helsetjenester.

Utvalgets flertall bestående av medlemmene Evensen, Alamdari, Bendiksen, Berggreen, Brekke, Feiring, Jakhelln, Kjenndalen, Lysaker, Onarheim, Rønning og Tovmo foreslår:

Forslag 11 A. Innføre prisregulering ved offentlig finansiering av tannhelsetjenester og utrede hvordan en slik regulering bør utformes

NTF støtter ikke dette forslaget.

Nærmere begrunnelse i DEL II punkt 3.1.

Utvalgets medlem Olsen-Bergem foreslår:

Forslag 11 B. Utrede prisregulering for tannhelsetjenester ved utvidelse av offentlig finansiering

NTF støtter dette forslaget.

Nærmere begrunnelse i DEL II punkt 3.1

Utvalgets flertall bestående av medlemmene Evensen, Bendiksen, Berggreen, Brekke, Feiring, Jakhelln, Kjenndalen, Lysaker, Onarheim, Rønning og Tovmo foreslår:

Forslag 12. Videreutvikle og gjenåpne prisportal for tannhelsetjenester ved innhenting av priser via Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Utvalgets mindretall bestående av medlemmene Alamdari og Olsen-Bergem støtter ikke forslaget.

NTF støtter ikke dette forslaget.

Nærmere begrunnelse i DEL II punkt 3.2

3 Tannhelsetjenester av god kvalitet

Forslag 13. Videreutvikle kvalitetsindikatorer for tannbehandling og gjøre dem offentlig tilgjengelig

NTF støtter dette forslaget.

Forslag 14. Etablere kvalitetsregistre for tannbehandling

NTF støtter dette forslaget.

NTF har i lang tid vært tydelige på at det er behov for kvalitetsregistre for tannbehandling. Et eksempel på et slikt register kan være et implantatregister. NTF er av den oppfatning at en utvidelse av KPR med data fra tannhelsetjenesten ikke nødvendigvis vil dekke behovet for kvalitetsregistre for tannbehandling og mener at det er behov for å opprette egne kvalitetsregistre.

Forslag 15. Øke tannhelsetjenestens regionale kompetansesentres bistand til privat tannhelsetjeneste

NTF støtter dette forslaget.

NTF har i lang tid påpekt at de ROKene i alt for stor grad har vært opptatt av samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten. Det er viktig at sentrene bidrar med tjenester til en samlet tannhelsetjeneste. NTF vil likevel understreke at i en modell med regionale tannhelseforetak, som NTF stiller seg bak, vil det være tannhelseforetaket som vil overta senternes oppgaver. NTF mener at en slik modell vil legge til rette for bedre samhandling ved løsning av nasjonale oppgaver og at tannhelseforetakene på en bedre måte kan tilpasse tjenestene sine til de regionale behovene i tjenesten, derunder bistand til og samarbeid med privat tannhelsetjeneste.

Forslag 16. Legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid i tannklinikk basert på KPR-data

NTF støtter dette forslaget.

NTF vil likevel understreke at vi er usikre på om datainnsamling via KPR vil være tilstrekkelig for å sikre gode kvalitetsregistre i tannhelsetjenesten, siden KPR ikke er opprettet for dette formålet.

Det må vurderes om det også er behov for andre kvalitetsregistre, for eksempel et implantatregister, som kan bidra til å legge til rette til systematisk kvalitetsarbeid slik at kvalitetsarbeidet ikke bare er avhengig av data i KPR.

Forslag 17. Utvikle kunnskapsstøttesystem og prioriteringsveiledere for tannhelsetjenesten

NTF støtter dette forslaget.

Det er avgjørende at man utreder hva som er nødvendig tannbehandling. I dette arbeidet må fagmiljøene og hele tjenesten, ved profesjonsforeningene, være sterkt representert. Når dette er gjort må det på bakgrunn av dette utvikles kunnskapsstøttesystem og prioriteringsveiledere for tannhelsetjenesten.

Forslag 18. Styrke praksisnær forskning på oral helse og tannhelsetjenester

NTF støtter dette forslaget.

NTF vil understreke at hele tannhelsetjenesten bør involveres i klinisk forskning og forskning på tannhelsetjenesten. NTF mener at dette best kan løses i en modell med regionalt tannhelseforetak. Det vil da være enklere å legges til rette for et godt samarbeid mellom

foretaket og de odontologiske lærestedene, hvor det i dag allerede er stor forskningsaktivitet. Det er uansett modell behov for å legge til rette for et bedre samarbeid mellom de ulike forskningsaktørene i tjenesten, og legge til rette for at hele tannhelsetjenesten bidrar i dette arbeidet. Tannhelsetjenesten er en liten tjeneste med små fagmiljøer og forskningsmiljøer. Det er bærekraftig bruk av ressurser å sikre god samhandling og riktig bruk av ressurser.

Forslag 19. Sikre at tannhelsetjenestens kompetansesentre får en regional funksjon og er landsdekkende

NTF støtter dette forslaget.

NTF mener at dette best kan løses i en regional tannhelseforetaksmodell. Da vil det være tannhelseforetaket som får ansvaret for tannhelsetjenesten i sin region, og de vil overta kompetansesentrene. Tannhelseforetakene vil innrette sine tilbud tilpasset behovet i regionen, og de vil kunne samarbeide om nasjonale oppgaver og med andre aktører, som aktørene i privat tannhelsetjeneste og de odontologiske lærestedene.

Mange fylkeskommuner er i dag ikke tilknyttet et odontologisk kompetansesenter. Det kan tyde på at sentrene ikke har funnet sin plass eller sin funksjon. I en modell hvor tannhelseforetaket tar over dagens regionale kompetansesenter kan hele ordningen evalueres og behovet tilpasses den enkelte region på en bedre måte enn i dag.

Forslag 20 A, B og C henger sammen med forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjeneste, nærmere omtalt i kapittel 15 Organisering av den offentlige tannhelsetjenesten.

Utvalgets flertall bestående av medlemmene Bendiksen, Berggreen, Brekke, Feiring, Kjenndalen, Onarheim og Tovmo foreslår:

Forslag 20 A. Overføre tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre til de regionale helseforetakene

NTF støtter ikke dette forslaget.

Utvalgets mindretall bestående av medlemmene Alamdari, Jakhelln, Lysaker og Olsen-Bergem foreslår:

Forslag 20 B. Overføre tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre til tannhelsetjenesten ved tannhelseforetak

NTF støtter dette forslaget.

Nærmere beskrivelse i DEL II punkt 2.2 og under anbefaling 15 og 19.

Utvalgets mindretall bestående av medlemmene Evensen og Rønning foreslår:

Forslag 20 C. Overføre tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre til den offentlige tannhelsetjenesten

NTF støtter ikke dette forslaget.

Forslag 21. Lovregulere et sørge for-ansvar for praksis i utdanningene

NTF støtter dette forslaget.

NTF mener at det er svært viktig å opprettholde praksis i alle tannhelseutdanningene. Det vil si tannlegeutdanningen, tannpleierutdanningen, tannteknikerutdanningen og utdanningen av tannhelsesekretærer. NTF er av den oppfatning at hele tannhelsetjenesten bør kunne involveres som praksisarenaer, og at et ansvar for å bidra i praksisutdanningene bør lovfestes.

NTF mener at dette ansvaret best kan løses i regional tannhelseforetaksmodell. I en slik modell vil dette være foretakets ansvar og det kan enklere inngås avtaler med de utdanningsinstitusjonene i tannhelsetjenesten og også med den private tannhelsetjenesten.

Forslag 22. Lovregulere et medvirkningsansvar for kommunal sektor for forskning i tannhelsetjenesten

NTF støtter dette forslaget.

NTF støtter ikke at tannhelsetjenesten overføres til kommunene. Men NTF støtter at det forvaltningsorgan som har ansvaret for tannhelsetjenesten, skal ha et lovregulert medvirkningsansvar for forskning i tannhelsetjenesten. NTF mener at dette ansvaret best kan løses i en modell med regionale tannhelseforetak.

Det må videre legges til rette for samhandling med forskningsmiljøer i andre helsetjenester og andre tjenester som er aktuelle å samarbeide med, samt for samarbeid med de odontologiske lærestedenes forskningsmiljøer.

Forslag 23. Styrke tannhelsetjenestens arbeid med å avdekke vold, overgrep og sykdom

NTF støtter dette forslaget.

Dette er en svært viktig oppgave for hele tannhelsetjenesten, og dette arbeidet bør styrkes.

Forslag 24. Regulere tannhelsetjenestens samarbeid med barneavdelingene i de regionale helseforetakene, barnevernet og Statens Barnehus

NTF støtter dette forslaget.

Forslag 25. Utrede digitale systemer for henvisning innad i tannhelsetjenesten og til alle deler av helse- og omsorgstjenesten

NTF støtter dette forslaget.

Det er helt avgjørende at tannhelsetjenesten involveres i digitaliseringsprosjekter i helsetjenesten, og at det utvikles gode tekniske løsninger som legger til rette for samarbeid og samhandling, både innad i tannhelsetjenesten og mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten og også andre samarbeidende tjenester.

Forslag 26. Gi tannhelsetjenesten økt tilgang til digitale verktøy

NTF støtter dette forslaget.

Det er helt avgjørende at tannhelsetjenesten involveres i digitaliseringsprosjekter i helsetjenesten, og at det utvikles gode tekniske løsninger som legger til rette for samarbeid og samhandling, både innad i tannhelsetjenesten og mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten.

4 Klageadgang, tilsyn og pasientsikkerhet

Forslag 27. Utarbeide retningslinjer for tannhelsetjenestens plikt til å informere om klagemuligheter etter behandling

NTF støtter dette forslaget.

Nærmere begrunnelse DEL II punkt 3.3.

Forslag 28. Utrede om det er behov for å styrke tilsynet med tannhelsetjenesten

NTF støtter dette forslaget.

Nærmere begrunnelse i DEL II punkt 3.4

Forslag 29. Innføre rett til en ny vurdering av tannhelsetilstand

NTF støtter dette forslaget.

I en modell hvor tannhelsetjenesten harmoniseres med resten av helsetjenesten og alle skal ha rett til nødvendig tannbehandling i frikortordningen, er det behov for å regulere når pasienten har krav på en ny vurdering dekket under frikortet, som i resten av helsetjenesten.

Forslag 30. Innføre hjemmel for å dele opplysninger om behov for tannhelsetjenester med den offentlige tannhelsetjenesten

NTF støtter dette forslaget.

Det må legges til rette for godt samarbeid og samhandling mellom tannhelsetjenesten og andre helsetjenester, og deling av nødvendig informasjon mellom tjenestene, også om behovet for tannhelsetjenester. I en universell modell hvor alle har rett til nødvendige tannhelsetjenester vil det være avgjørende å utnytte ressursene i både privat og offentlig tannhelsetjeneste. Det vil derfor være avgjørende at slike opplysninger som deles med den offentlige tannhelsetjenesten også kan deles med behandlere i privat tannhelsetjeneste, enten direkte eller via den offentlige tannhelsetjenesten.

5 Samhandling, styring og ansvar for tannhelsetjenesten

Forslag 31. Inkludere den offentlige tannhelsetjenesten i helsefelleskapene

NTF støtter dette forslaget.

NTF mener det er avgjørende for at disse pasientgruppene skal få et helhetlig tilbud at den offentlige tannhelsetjenesten inkluderes i helsefelleskapene.

Forslag 32. Innføre lovpålagte samarbeidsavtaler mellom den offentlige tannhelsetjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester

NTF støtter dette forslaget.

Det er avgjørende for god samhandling at det foreligger avtaler mellom tannhelsetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester.

Forslag 33. Tydeliggjøre den offentlige tannhelsetjenestens ansvar for samordning og styring ved kriser, og tydeliggjøre den private tannhelsetjenestens plikt til å delta

NTF støtter dette forslaget.

Det er avgjørende at tannhelsetjenesten inkluderes i alle beredskapsplaner og at ansvaret til den offentlige tannhelsetjenesten tydeliggjøres. Privat tannhelsetjeneste må også inkluderes og denne plikten må tydeliggjøres.

Utvalget peker på HPR-registeret. Dette er et register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, men det sier ingen ting om hvilket helsepersonell som arbeider i Norge, eller hvor de arbeider. NTF har i lang tid etterspurt et bedre register over tilgjengelig helsepersonell i Norge.

Forslag 34. Utrede behov for studieplasser for tannhelsepersonell i Norge

NTF støtter dette forslaget.

Norge bør utdanne mesteparten av sitt eget tannhelsepersonell (80 % av tannleger etter modell fra Grimstadutvalget som anbefalte dette for utdanning av leger²³). Dette gjelder både tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere.

SSB anslår at det går mot et overskudd av tannleger. NTF vil understreke at dette er svært usikre beregninger, som ikke på noen måte tar høyde for en slik endring som Tannhelseutvalget her foreslår. Hvis hele befolkningen skal ha rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester må det gjøres helt nye beregninger med bakgrunn i dette. NTF mener derfor at en slik utredning er avgjørende. Det etiske perspektivet og beredskapsperspektivet tilsier også at Norge bør utdanne sitt eget tannhelsepersonell og ikke være avhengig av at vårt helsepersonell utdannes i andre land. Det er dessuten avgjørende at helsepersonellet som skal arbeide i Norge har inngående kunnskap om norsk helsetjeneste, inkludert lovverk som regulerer tjenestene.

Alle yrkesgruppene i tannhelsetjenesten har ulik utdanning og kompetanse, og sine særskilte oppgaver, som til sammen utgjør tannhelseteamet. For en velfungerende tannhelsetjeneste er det avgjørende med tilgang til nok tannhelsepersonell i alle kategorier.

NTF er spesielt bekymret for mangelen på autoriserte tannhelsesekretærer, og vi vil også understreke at det er avgjørende å beholde tannteknikerutdanning i Norge, både fra et beredskapshensyn, men også fra et bærekraftshensyn. Pasientene vil ha behov for protetiske erstatninger i fremtiden, og hvis vi ikke har tilstrekkelig med tannteknikerkompetanse i Norge

²³ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/studieplasser-i-medisin-i-norge/id2670032/>

gjør vi oss avhengige av import fra utlandet. Alternativet er å hente tannteknikere fra andre land, noe som er krevende ut fra et etisk perspektiv.

Forslag 35. Styrke arbeidet med sambruk av personell i kommunene, særlig av tannpleiere, overfor barn og unge samt grupper med særskilt behov

NTF støtter dette forslaget.

NTF støtter at tannpleiere i større grad enn i dag bør ha en rolle i aktivt helsefremmende og forebyggende arbeid, og da spesielt overfor barn og unge samt grupper med særskilt behov. Det er viktig med et tettere samarbeid med resten av helse- og omsorgstjenestene og det må legges til rette for bedre opplæring av personellet i helse- og omsorgstjenesten.

NTF vil likevel påpeke at det er avgjørende med samhandling og inkludering også av tannleger og spesialistkompetanse ved behov. I mange tilfeller er det behov for denne kompetansen spesielt ved diagnostikk og behandlingsplanlegging. Vi ser at tannpleiere er viktige i forebyggende arbeid og i oppfølging av enkeltbrukere, men det er også viktig at man erkjenner begrensningene og involverer annet personell ved behov. Diagnostikk legger grunnlaget for all videre behandling, og for de pasientene som har særskilte behov er det oftere behov for kommunikasjon med leger, fysioterapeuter, logopeder, ernæringsfysiologer og andre som jobber rundt pasienten. Tannpleier og tannleger har ulik utdanning, ulik kompetanse og bør utfylle hverandre. Ingen pasienter, og spesielt ikke de med særskilte behov, bør utelukkende tilsees av tannpleiere, slik det er i deler av dagens tannhelsetjeneste. Samhandling og best mulig utnyttelse av den samlede kompetansen er igjen stikkord.

NTF ser også et behov for odontologisk kompetanse på, eller tett på, øverste ledernivå i tjenestene, for å skape de gode løsningene.

6 Tydeliggjøre rammene for utøvelse av privat virksomhet

Forslag 36. Styrke tilsyn med private tannhelsetilbydere for å sikre etterlevelse i henhold til rammene for utøvelse av privat virksomhet

NTF støtter dette forslaget.

Nærmere begrunnelse DEL II punkt 3.4.

Utvalgets flertall bestående av medlemmene Evensen, Bendiksen, Berggreen, Brekke, Feiring, Kjenndalen, Lysaker, Onarheim, Rønning og Tovmo foreslår:

Forslag 37. Innføre lovfestede krav for private tannhelsetilbydere om å søke konsesjoner for klinikkdrift

NTF støtter ikke dette forslaget.

Nærmere begrunnelse DEL II punkt 3.5.

Utvalgets mindretall bestående av medlemmene Evensen og Rønning foreslår i tillegg:

Forslag 38. Innføre et lovfestede krav for private tannhelsetilbydere om å søke konsesjoner for eierskap av tannklinikker

NTF støtter ikke dette forslaget.

Nærmere begrunnelse DEL II punkt 3.5.

Utvalgets mindretall bestående av medlemmene Alamdari, Jakhelln og Olsen-Bergem støtter hverken forslag 37 eller 38

7 Tannhelsesdata som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av tannhelsetjenesten

Forslag 39. Samle tannhelsesdata i Kommunalt pasient- og brukerregister, og Norsk pasientregister og analysere innrapporterte data.

NTF støtter dette forslaget.

Forslag 40. Tydeliggjøre den offentlige tannhelsetjenestens overordnede ansvar for å tilby tannhelsetjenester til befolkningen, inkludert ansvar for folkehelsearbeid, beredskap og dimensjonering av tannhelsetjenesten

NTF støtter dette forslaget.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Heming Olsen-Bergem
president

Anne Farseth
generalsekretær

Dokumentet er elektronisk signert av Heming Olsen-Bergem og Anne Farseth den 14.03.2025.